ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

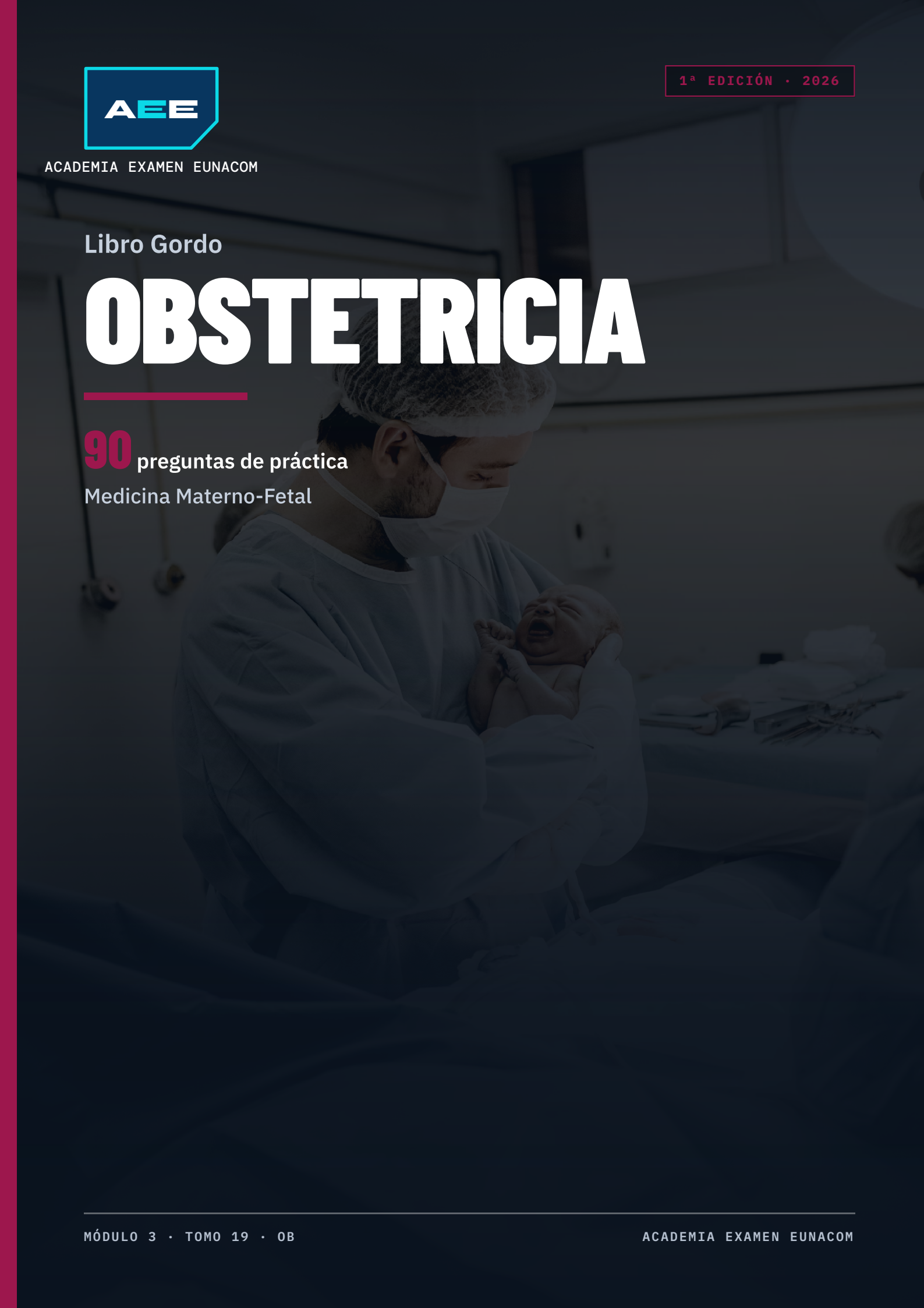
1ª EDICIÓN · 2026

Libro Gordo

OBSTETRICIA

90 preguntas de práctica

Medicina Materno-Fetal



MATRIZ PERFIL V3 · DISTRIBUCIÓN POR BLOQUES

Obstetricia · Secuencia Cardinal de Estudio (Bloque 1 a 5)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
BLOQUE 1: CONTROL PRENATAL & EVALUACIÓN FETAL					
3.01.1.010	Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18	Tomo 19 · 19.4 (Pág. 11)
3.01.1.031	VIH en ginecobstetricia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q1	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.017	Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q2	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.3.001	Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q3, Q4	Tomo 19 · 19.1 (Pág. 5)
3.01.4.003	Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q5, Q6	Tomo 19 · 19.2 (Pág. 7)
3.01.5.009	Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q7, Q8	Tomo 19 · 19.3 (Pág. 9)
BLOQUE 2: PATOLOGÍAS MÉDICAS DEL EMBARAZO					
3.01.1.003	Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q34, Q35, Q36	Tomo 19 · 19.8 (Pág. 28)
3.01.1.004	Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q29, Q30, Q31, Q32, Q33	Tomo 19 · 19.7 (Pág. 24)
3.01.1.011	Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q20, Q21, Q22	Tomo 19 · 19.5 (Pág. 18)
3.01.2.003	Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q23	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.004	Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q24, Q25, Q26, Q27, Q28	Tomo 19 · 19.6 (Pág. 20)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
	HELLP y Sulfato de Magnesio				
3.01.2.007	Hiperemesis gravídica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	—	Q19	Tomo 19 · 19.21 (Pág. 32)
BLOQUE 3: PATOLOGÍAS MÉDICAS DEL EMBARAZO					
3.01.1.001	Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q38, Q39, Q40, Q41, Q42	Tomo 19 · 19.10 (Pág. 37)
3.01.1.002	Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **No requiere**	GES	Q45, Q46, Q47, Q48, Q49	Tomo 19 · 19.11 (Pág. 41)
3.01.1.003	Enfermedad Trofoblástica Gestacional: Mola Completa vs Parcial, Criterios de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) y Seguimiento	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Completo**	GES	Q51, Q52	Tomo 19 · 19.8 (Pág. 28)
3.01.1.019	Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q53, Q54	Tomo 19 · 19.9 (Pág. 30)
3.01.2.001	Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q43	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.005	Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q50	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.010	Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q44	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.013	Presentaciones fetales anómalas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q37	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
BLOQUE 4: METRORRAGIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO					
3.01.1.004	Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q55, Q56, Q57, Q58	Tomo 19 · 19.7 (Pág. 24)
3.01.1.005	Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q61, Q62, Q63, Q64, Q65	Tomo 19 · 19.14 (Pág. 54)
3.01.1.006	Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q68, Q69, Q70	Tomo 19 · 19.15 (Pág. 58)
3.01.1.007	Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q71	Tomo 19 · 19.21 (Pág. 32)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
3.01.2.011	Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q59	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.012	Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q66	Tomo 19 · C.38 (Pág. 80)
3.01.2.014	Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q67	Tomo 20 · C.40 (Pág. 84)
3.01.2.015	Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q60	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.021	Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q72	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
BLOQUE 5: PARTO PREMATURO, MECANISMO DEL PARTO, PUERPERIO & URGENCIAS OBSTÉTRICAS					
3.01.1.008	Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79	Tomo 19 · 19.17 (Pág. 64)
3.01.1.009	Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q80, Q81, Q82, Q83, Q84	Tomo 19 · 19.18 (Pág. 68)
3.01.1.010	Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q85, Q86	Tomo 19 · 19.4 (Pág. 11)
3.01.1.012	Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal: Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D y Manejo de la Gestante Sensibilizada	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q89, Q90	Tomo 19 · 19.20 (Pág. 74)
3.01.2.006	Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q87	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.009	Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q88	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)

ÍNDICE CORRELATIVO OFICIAL PERFIL V3

Obstetricia · Códigos en Orden Numérico Correlativo Estricto (Sin Bloques)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
3.01.1.001	Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q38, Q39, Q40, Q41, Q42	Tomo 19 · 19.10 (Pág. 37)
3.01.1.002	Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **No requiere**	GES	Q45, Q46, Q47, Q48, Q49	Tomo 19 · 19.11 (Pág. 41)
3.01.1.003	Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q34, Q35, Q36, Q51, Q52	Tomo 19 · 19.8 (Pág. 28)
3.01.1.004	Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q29, Q30, Q31, Q32, Q33, Q55, Q56, Q57, Q58	Tomo 19 · 19.7 (Pág. 24)
3.01.1.005	Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q61, Q62, Q63, Q64, Q65	Tomo 19 · 19.14 (Pág. 54)
3.01.1.006	Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q68, Q69, Q70	Tomo 19 · 19.15 (Pág. 58)
3.01.1.007	Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q71	Tomo 19 · 19.21 (Pág. 32)
3.01.1.008	Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q73, Q74, Q75, Q76, Q77, Q78, Q79	Tomo 19 · 19.17 (Pág. 64)
3.01.1.009	Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q80, Q81, Q82, Q83, Q84	Tomo 19 · 19.18 (Pág. 68)
3.01.1.010	Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q85, Q86	Tomo 19 · 19.4 (Pág. 11)
3.01.1.011	Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q20, Q21, Q22	Tomo 19 · 19.5 (Pág. 18)
3.01.1.012	Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal: Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q89, Q90	Tomo 19 · 19.20 (Pág. 74)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
	D y Manejo de la Gestante Sensibilizada				
3.01.1.019	Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q53, Q54	Tomo 19 · 19.9 (Pág. 30)
3.01.1.031	VIH en ginecobstetricia	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q1	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.001	Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q43	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.003	Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q23	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.004	Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q24, Q25, Q26, Q27, Q28	Tomo 19 · 19.6 (Pág. 20)
3.01.2.005	Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q50	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.006	Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q87	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.007	Hiperemesis gravídica	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	—	Q19	Tomo 19 · 19.21 (Pág. 32)
3.01.2.009	Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q88	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.010	Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q44	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.011	Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q59	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.012	Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q66	Tomo 19 · C.38 (Pág. 80)
3.01.2.013	Presentaciones fetales anómalas	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	—	Q37	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.014	Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q67	Tomo 20 · C.40 (Pág. 84)

CÓDIGO V3	SITUACIÓN CLÍNICA / PATOLOGÍA	NIVEL LEGAL EXIGIDO	GES	PREGUNTAS	MANUAL DE ESTUDIO AEE
	Antibiótica y Corioamnionitis				
3.01.2.015	Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **No requiere**	GES	Q60	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.017	Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre	Dx: **Sospecha** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q2	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.2.021	Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q72	Tomo 19 · Obstetricia y Ginecología (Pág. 8)
3.01.3.001	Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre	Dx: **Específico** Tx: **Completo** · Seg: **Completo**	GES	Q3, Q4	Tomo 19 · 19.1 (Pág. 5)
3.01.4.003	Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría)	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q5, Q6	Tomo 19 · 19.2 (Pág. 7)
3.01.5.009	Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal	Dx: **Específico** Tx: **Inicial** · Seg: **Derivar**	GES	Q7, Q8	Tomo 19 · 19.3 (Pág. 9)

SECCIÓN I · CUADERNILLO DE PREGUNTAS (1 A 90)

Organizado estrictamente por Bloques Cardinales · Responda sin consultar la solución

90 ÍTEMS

BLOQUE 1 CONTROL PRENATAL & EVALUACIÓN FETAL

PREGUNTA 1 3.01.1.031

1. Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 32 semanas, sin controles previos, se realiza un Elisa para VIH, que resulta positivo. ¿Cuál es la conducta más importante para evitar la transmisión vertical?

A) Iniciar triterapia antirretroviral ahora
B) Realizar cesárea ahora
C) Iniciar triterapia antirretroviral si la carga viral es alta
D) Administrar terapia antirretroviral durante el trabajo de parto
E) Realizar cesárea al llegar a las 38 semanas

PREGUNTA 2 3.01.2.017

2. Una mujer de 38 de años, cursando un embarazo de término, inicia trabajo de parto. Actualmente tiene 7 cm de dilatación y se palpa la cabeza fetal ascendida, 2 centímetros por sobre las espinas isquiáticas. Presenta dinámica uterina de 4 a 5 contracciones uterinas cada 10 minutos, recibiendo goteo oxitócico. Luego de 2 horas de observación no se presentan cambios en las condiciones obstétricas y, poco después, aparecen múltiples desaceleraciones tardías en el monitoreo fetal y el líquido amniótico se tiñe de meconio. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Suspender oxitocina, lateralizar y controlar por 30 minutos
B) Realizar operación cesárea de inmediato
C) Administrar anestesia epidural y conducir el trabajo de parto
D) Aumentar la dosis de oxitocina y, una vez que se logre el descenso de la cabeza, realizar fórceps
E) Solicitar ecografía Doppler fetal

PREGUNTA 3 3.01.3.001

3. Una mujer de 26 años con antecedente de un hijo previo nacido con mielomeningocele lumbosacro planifica un nuevo embarazo. Acude a consulta preconcepcional para orientación médica. ¿Cuál es la indicación de suplementación con ácido fólico recomendada para reducir el riesgo de recurrencia de defectos del tubo neural?

A) 0.4 mg al día iniciando al confirmar el test de embarazo positivo en orina
B) 4.0 a 5.0 mg al día por vía oral, iniciado al menos 3 meses antes de la concepción y mantenido hasta las 12 semanas de gestación
C) 1.0 mg al día durante todo el segundo y tercer trimestre exclusivamente
D) 10 mg semanales en inyección intramuscular única
E) No requiere suplementación si consume cereales y harinas fortificadas

PREGUNTA 4 3.01.3.001

4. Una primigesta de 36 semanas de gestación acude a control prenatal habitual en APS. Se revisa el resultado del cultivo vaginorrectal tomado a las 35 semanas, el cual informa: desarrollo abundante de Streptococcus agalactiae (Streptococcus grupo B). La paciente se encuentra totalmente asintomática. ¿Cuál es la conducta médica correcta?

A) Indicar Amoxicilina oral ambulatoria por 7 días de inmediato para erradicar la bacteria
B) Realizar cesárea electiva de urgencia para evitar el paso del feto por el canal vaginal
C) Consignar el resultado en el carné prenatal e indicar que recibirá Penicilina G endovenosa durante el trabajo de parto activo
D) Indicar óvulos vaginales de Metronidazol por 10 noches
E) Repetir el cultivo vaginorrectal cada semana hasta que resulte negativo

PREGUNTA 5 3.01.4.003

5. A una primigesta de 12 semanas se le realiza la ecografía de primer trimestre. Se constata Doppler de arterias uterinas patológico con un Índice de Pulsatilidad medio superior al percentil 95. ¿Cuál es la intervención preventiva con mayor evidencia para reducir el riesgo de desarrollar preeclampsia severa y restricción de crecimiento fetal?

A) Reposo absoluto en cama en decúbito lateral izquierdo
B) Iniciar Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) a dosis de 150 mg al día por vía oral antes de las 16 semanas
C) Iniciar Enoxaparina subcutánea a dosis de anticoagulación plena
D) Dieta hiposódica estricta sin sal y diuréticos tiazídicos
E) Prescribir Nifedipino oral como antihipertensivo profiláctico

PREGUNTA 6 3.01.4.003

6. Durante la ecografía morfológica de las 22 semanas en una paciente asintomática sin antecedentes mórbidos, se realiza cervicometría transvaginal que informa una longitud endocervical cerrada de 18 mm. ¿Cuál es la conducta terapéutica indicada para prevenir el parto prematuro?

A) Cerclaje cervical de emergencia inmediato
B) Indicar Progesterona natural micronizada por vía vaginal a 200 mg diarios cada noche hasta la semana 36
C) Hospitalización e inicio de tocolíticos orales con nifedipino profiláctico
D) Indicar reposo domiciliario relativo sin medicamentos
E) Instalación de pesario cervical sin progesterona

PREGUNTA 7 3.01.5.009

7. Se realiza un Registro Basal No Estresante (RBNE) a una embarazada de 37 semanas por disminución transitoria de movimientos fetales. En los primeros 20 minutos de trazado se observa: FCF basal de 130 lpm, variabilidad de 8 lpm, ausencia de aceleraciones y ausencia de desaceleraciones. ¿Cuál es la conducta médica inmediata más adecuada?

A) Indicar cesárea de urgencia por sufrimiento fetal agudo
B) Prolongar el registro por 20 minutos adicionales y aplicar estímulo acústico o táctil al feto para descartar ciclo de sueño fisiológico
C) Hospitalizar en UCI de adultos para infusión de sulfato de magnesio
D) Considerar el examen 100% normal y dar el alta definitiva sin más controles
E) Administrar un bolo de 1.000 mL de suero fisiológico y realizar amniocentesis

PREGUNTA 8 3.01.5.009

8. En una paciente de 36 semanas con sospecha de deterioro de la función placentaria se realiza un Perfil Biofísico Fetal ecográfico de Manning. Se obtienen los siguientes resultados: sin movimientos respiratorios en 30 min (0 pts), 1 movimiento corporal único (0 pts), tono flexor conservado (2 pts), líquido amniótico con bolsillo vertical máximo de 0.8 cm (0 pts) y RBNE no reactivo (0 pts). Puntaje total: 2/10. ¿Cuál es la conducta clínica indicada?

A) Repetir el examen en 48 horas en forma ambulatoria
B) Interrupción inmediata del embarazo por riesgo crítico de asfixia y óbito fetal
C) Indicar reposo en cama e hidratación oral con abundante agua
D) Administrar betametasona y diferir el parto por al menos 5 días
E) Iniciar antibióticos profilácticos orales y control semanal

PREGUNTA 9 3.01.1.010

9. Una paciente de 34 años, tiene un embarazo de 35 semanas, con feto creciendo en el percentil 2, desde la semana 33, con Doppler fetal normal, en ese entonces. Se solicita un nuevo Doppler fetal de control, que no muestra alteraciones. La conducta más adecuada es:

A) Inducir el parto
B) Realizar cesárea
C) Solicitar perfil biofísico
D) Controlar semanalmente con el Doppler
E) Interrumpir a las 37 semanas

PREGUNTA 10 3.01.1.010

10. Una embarazada de 33 semanas de gestación se realiza ecografía que muestra una Estimación de Peso Fetal en el percentil 6. La velocimetría Doppler revela: arteria umbilical con Índice de Pulsatilidad normal (< P95), arteria cerebral media normal (> P5) y arterias uterinas normales. El líquido amniótico es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado y la conducta a seguir?

A) Restricción de crecimiento fetal severa; indicar cesárea inmediata
B) Pequeño para la edad gestacional constitucional (PEG); mantener controles habituales y programar parto a término (39-40 semanas)
C) Restricción de crecimiento fetal etapa II; hospitalizar e inducir el parto a las 34 semanas
D) Sufrimiento fetal agudo; realizar amniocentesis diagnóstica
E) Feto adecuado para la edad gestacional normal

PREGUNTA 11 3.01.1.010

11. En el seguimiento Doppler de un feto de 30 semanas con restricción de crecimiento fetal severa, se pesquisa la presencia de flujo reverso persistente durante la sístole auricular (onda 'a' reversa) en el Ductus Venoso. ¿Cuál es el significado fisiopatológico y la conducta médica inmediata?

A) Signo de madurez pulmonar avanzada; alta a domicilio
B) Signo de falla miocárdica y acidosis metabólica fetal crítica; interrupción inmediata del embarazo por cesárea bajo neuroprotección con sulfato de magnesio
C) Variante anatómica benigna sin repercusión hemodinámica
D) Indicar infusión de glucosa materna para revertir la onda 'a'
E) Programar nuevo control ecográfico en 2 semanas

PREGUNTA 12 3.01.1.010

12. Una paciente de 30 años, cursando un embarazo de 37 semanas, tiene una altura uterina de 28 cm. Se realiza una ecografía obstétrica, que muestra un feto creciendo en percentil 8, con ILA de 8 cm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Inducir el parto con misoprostol
B) Realizar registro basal no estresante
C) Observar evolución
D) Realizar doppler materno fetal
E) Realizar operación cesárea

PREGUNTA 13 3.01.1.010

13. Una paciente cursando un embarazo de 35 semanas, es diagnosticada de RCIU en percentil 3. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es una indicación de interrupción inmediata del embarazo?

A) Oligohidroamnios
B) Aumento de la resistencia de las arterias umbilicales
C) Dilatación de la arteria cerebral media
D) Relación femoro/abdominal mayor a 0,25
E) Ducto venoso con flujo ausente en diástole, al doppler

PREGUNTA 14 3.01.1.010

14. Una paciente multípara, de 40 años, cursando un embarazo de 32 semanas, se realiza una ecografía obstétrica, que muestra líquido amniótico sin alteraciones, con un feto creciendo en percentil 10 para la edad gestacional, con un peso fetal estimado de 1.320 gramos. ¿Cuál es la actitud más adecuada?

A) Observar evolución
B) Solicitar ecodoppler uterina
C) Solicitar ecodoppler umbilical
D) Repetir la ecografía obstétrica en 2 semanas
E) Inducir maduración pulmonar con corticoides

PREGUNTA 15 3.01.1.010

15. **Una paciente de 30 años, cursando embarazo de 36 semanas, con feto creciendo en percentil 6 en la semana 35, con Doppler materno fetal normal en ese entonces. Se realiza ecografía de control que muestra feto que no ha crecido, en presentación podálica y Doppler normal. El registro basal no estresante es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar perfil biofísico
B) Administrar corticoides
C) Interrumpir a las 37 semanas
D) Realizar cesárea en este momento
E) Continuar el control semanal con Doppler

PREGUNTA 16 3.01.1.010

16. **Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 37 semanas, tiene una estimación de peso fetal en el percentil 5 para la edad gestacional. Se realiza una ecografía obstétrica, que confirma feto con peso en percentil 5 para la edad e índice de líquido amniótico de 6. La conducta más adecuada es:**

A) Solicitar registro basal no estresante
B) Inducir el parto
C) Solicitar Doppler maternofetal
D) Realizar amnioinfusión
E) Realizar cesárea

PREGUNTA 17 3.01.1.010

17. **Una paciente de 34 años, cursando un embarazo de 38 semanas, con antecedente de RCIU en percentil 5. Se realiza una ecografía obstétrica, que muestra feto creciendo en percentil menor a 5 y oligohidroamnios. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Administrar corticoides, manteniendo una conducta expectante
B) Realizar cesárea dentro de las próximas 24 horas
C) Inducir el parto con misoprostol
D) Solicitar doppler umbilical y decidir según resultados
E) Realizar test de tolerancia a las contracciones

PREGUNTA 18 3.01.1.010

18. **Embarazada de 35 semanas, con altura uterina menor a lo esperado, es derivada a alto riesgo obstétrico donde se realiza ecografía que muestra feto de 1.800 gramos y el doppler umbilical muestra flujo reverso en diástole. La paciente está en buenas condiciones, sin dinámica uterina y su tacto vaginal no presenta cambios cervicales. La conducta más adecuada es:**

A) Inducir con misoprostol y conducir trabajo de parto
B) Interrumpir por cesárea
C) Hospitalizar para estudio de la unidad fetoplacentaria
D) Solicitar estudio de líquido amniótico
E) Indicar reposo y control en 48 horas

BLOQUE 2 PATOLOGÍAS MÉDICAS DEL EMBARAZO

PREGUNTA 19 3.01.2.007

19. **Una paciente de 18 años, cursando un embarazo de 11 semanas, presenta vómitos frecuentas, desde inicios del embarazo, pero que han ido en aumento. Hace 24 horas ha empeorado, al punto que no ha podido ingerir líquidos adecuadamente, por lo que acude al servicio de urgencia. El diagnóstico más probable es:**

A) Gastroparesia gestacional
B) Cólico biliar
C) Hepatitis
D) Hiperemesis gravídica
E) Síndrome de HELLP

PREGUNTA 20 3.01.1.011

20. **Una paciente de 32 años con antecedente de síndrome hipertensivo del embarazo, a las 32 semanas no logra cifras tensionales normales a pesar de las medidas no farmacológicas. ¿Cuál de los siguientes fármacos es más adecuado para continuar con el tratamiento?**

A) Losartán
B) Enalapril
C) Nifedipino
D) Espironolactona
E) Doxazosina

PREGUNTA 21 3.01.1.011

21. **Una primigesta de 32 semanas de gestación acude a control prenatal. Se constata presión arterial de 145/95 mmHg, repetida a las 4 horas con 148/94 mmHg. Se encuentra asintomática, sin cefalea ni escotomas. La proteinuria de 24 horas informa 450 mg (normal < 300 mg). El recuento de plaquetas es de 210.000/mm³, creatinina 0.7 mg/dL y transaminasas normales. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado?**

A) Hipertensión arterial crónica
B) Hipertensión gestacional transitoria
C) Preeclampsia sin criterios de severidad
D) Síndrome HELLP incipiente
E) Eclampsia inminente

PREGUNTA 22 3.01.1.011

22. **¿Cuál de los siguientes fármacos antihipertensivos está CONTRAINDICADO DE FORMA ABSOLUTA durante el segundo y tercer trimestre del embarazo debido a su asociación con hipoplasia pulmonar, oligohidramnios y falla renal fetal anúrica irreversible?**

A) Labetalol
B) Alfa-metildopa
C) Enalapril
D) Nifedipino
E) Hidralazina

PREGUNTA 23 3.01.2.003

23. Embarazada de 36 semanas con presión arterial 170/110 y cefalea frontal intensa que no cede con analgesia. Sin convulsiones. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

A) Hospitalizar, labetalol EV para control de PA, sulfato de magnesio profiláctico e interrupción del embarazo
B) Nifedipino oral y control ambulatorio
C) Sulfato de magnesio solo
D) Inducción con oxitocina inmediata sin otro manejo
E) Hidralazina oral y observar

PREGUNTA 24 3.01.2.004

24. Una paciente de 25 años, primigesta con 32 semanas de gestación, presenta cefalea intensa y malestar general. Al examen Fsico destaca una presión arterial de 170/110 mmHg, por lo que se administra labetalol endovenoso, logrando cifras tensionales de 140/90 mmHg. Sin embargo, dos horas después presenta una convulsión tónico-clónica de 2 minutos de duración. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar lorazepam endovenoso
B) Administrar labetalol endovenoso
C) Administrar sulfato de magnesio endovenoso
D) Administrar tocolí2cos endovenosos
E) Realizar maduración pulmonar

PREGUNTA 25 3.01.2.004

25. Una paciente de 34 semanas con diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad se encuentra en tratamiento con infusión continua de Sulfato de Magnesio a 2 g/hora. Al realizar el control clínico horario, el médico constata: paciente somnolienta pero orientada, frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto y ausencia completa del reflejo rotuliano bilateral. La diuresis de la última hora fue de 15 mL. ¿Cuál es la conducta médica inmediata?

A) Aumentar la infusión de sulfato de magnesio a 3 g/hora para asegurar efecto anticonvulsivante
B) Suspender de inmediato la infusión de Sulfato de Magnesio y administrar Gluconato de Calcio al 10% 1 g por vía endovenosa lenta
C) Administrar un bolo de Diazepam endovenoso
D) Realizar intubación orotraqueal sin administrar antídotos
E) Indicar Furosemida endovenosa para forzar la diuresis

PREGUNTA 26 3.01.2.004

26. Una embarazada de 32 semanas consulta en urgencia por dolor epigástrico intenso y constante irradiado al hipocondrio derecho y náuseas. PA: 165/105 mmHg. En los exámenes de laboratorio se constata: Hemoglobina 9.2 g/dL, Frotis con abundantes esquistocitos, LDH 880 U/L, Bilirrubina total 2.4 mg/dL a predominio indirecto, GOT/AST 160 U/L, GPT/ALT 145 U/L y recuento de plaquetas de 62.000/mm³. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta obstétrica definitiva?

A) Hepatitis viral aguda; manejo médico ambulatorio con reposo
B) Colecistitis aguda litiásica; colecistectomía laparoscópica de urgencia
C) Síndrome HELLP; estabilización materna con sulfato de magnesio, antihipertensivos e interrupción del embarazo
D) Púrpura trombocitopénico trombótico; plasmaféresis de urgencia manteniendo el embarazo
E) Hígado graso agudo del embarazo; manejo expectante con corticoides por 7 días

PREGUNTA 27 3.01.2.004

27. Durante el trabajo de parto de una primigesta de 38 semanas con preeclampsia severa, se registra una presión arterial sostenida de 175/115 mmHg. La paciente refiere cefalea frontal punzante. ¿Cuál es el fármaco de rescate endovenoso de primera línea para el control rápido de la crisis hipertensiva en este contexto?

A) Nitroprusiato de sodio en infusión continua
B) Labetalol endovenoso en bolos crecientes (20 mg inicial, luego 40 y 80 mg)
C) Enalapril endovenoso a 1.25 mg
D) Furosemida endovenosa en bolo de 40 mg
E) Nifedipino sublingual mordido

PREGUNTA 28 3.01.2.004

28. ¿Cuál es la causa directa más frecuente de muerte materna en pacientes que sufren una crisis de Eclampsia?

A) Ruptura uterina masiva
B) Hemorragia intracerebral / Accidente cerebrovascular hemorrágico
C) Insuficiencia renal aguda tubular
D) Shock anafiláctico por sulfato de magnesio
E) Embolia de líquido amniótico

PREGUNTA 29 3.01.1.004

29. Una mujer de 35 años, con embarazo de 15 semanas, sin síntomas, en exámenes de control destaca VDRL negativo, hemoglobina de 11,5 mg/dL y glicemia de ayuno 108mg/dL. Su examen físico es normal, con altura uterina sobre el pubis. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Solicitar test de tolerancia oral a la glucosa
B) Indicar dieta y mantener control habitual
C) Solicitar hemoglobina glicosilada
D) Indicar insulina subcutánea
E) Solicitar nueva glicemia de ayunas

PREGUNTA 30 3.01.1.004

30. Una primigesta de 26 semanas sin antecedentes mórbidos se realiza la Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral con 75 g (PTGO 75g). Los resultados informan: Glicemia basal de 86 mg/dL y Glicemia a las 2 horas de 152 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta inicial correcta?

A) Examen normal; citar a control prenatal habitual en 4 semanas
B) Intolerancia a la glucosa del embarazo; repetir la prueba a las 32 semanas
C) Diabetes Gestacional; iniciar terapia nutricional fraccionada y automonitoreo glucémico capilar
D) Diabetes Pregestacional; hospitalizar de inmediato para bomba de insulina endovenosa
E) Diabetes Gestacional; iniciar Metformina oral 850 mg cada 12 horas como fármaco de elección

PREGUNTA 31 3.01.1.004

31. Una paciente con Diabetes Gestacional en tratamiento con dieta estricta desde hace 2 semanas trae su registro de glicemias capilares ambulatorias (4 controles diarios: ayunas y 2 horas post desayuno, almuerzo y cena). De 28 controles realizados en la semana, 8 controles postprandiales se sitúan entre 135 y 150 mg/dL (metas: ayunas < 95 mg/dL, 2 horas < 120 mg/dL). ¿Cuál es la conducta médica indicada?

A) Mantener solo la dieta y reevaluar en 1 mes
B) Iniciar tratamiento farmacológico con Insulina
C) Indicar ayuno prolongado saltándose la cena
D) Prescribir Glibenclamida oral
E) Interrumpir el embarazo de inmediato por vía cesárea

PREGUNTA 32 3.01.1.004

32. ¿Cuál de las siguientes complicaciones neonatales se asocia DIRECTAMENTE con la hiperglicemia materna no controlada durante el embarazo mediante el mecanismo de hiperinsulinismo fetal reactivo?

A) Hiperglicemia neonatal cetósica en las primeras horas de vida
B) Hipoglicemia neonatal sintomática severa en las primeras 2 a 4 horas de vida
C) Anemia hemolítica autoinmune
D) Agenesia renal bilateral congénita
E) Hipercalcemia neonatal idiopática

PREGUNTA 33 3.01.1.004

33. A una embarazada de 10 semanas se le realiza su primer control prenatal. La glicemia plasmática en ayunas resulta en 108 mg/dL. Se repite a los 4 días en ayunas y arroja 106 mg/dL. ¿Cuál es el diagnóstico según la normativa perinatal de Chile?

A) Embarazo normal; el corte de ayunas en el primer trimestre es 110 mg/dL
B) Diabetes Gestacional precoz
C) Diabetes Mellitus pregestacional manifiesta
D) Intolerancia a los carbohidratos que no requiere seguimiento
E) Falso positivo por estrés del primer trimestre

PREGUNTA 34 3.01.1.003

34. Una paciente de 25 años, con 33 semanas de embarazo, consulta por prurito de predominio palmo-plantar, pero que en ocasiones es generalizado. Refiere que es más intenso en la noche. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico?

A) Transaminasas
B) Ecografía abdominal
C) Ácidos biliares
D) Fosfatasas alcalinas
E) Bilirrubina total y diferenciada

PREGUNTA 35 3.01.1.003

35. Una embarazada de 33 semanas consulta por prurito intenso en palmas de las manos y plantas de los pies que empeora por las noches desde hace una semana. Al examen físico no presenta erupciones cutáneas, solo lesiones lineales de rascado. Las pruebas hepáticas muestran GOT 85 U/L y GPT 110 U/L con bilirrubina total de 0.9 mg/dL. Los ácidos biliares séricos resultan en 54 umol/L. ¿Cuál es el diagnóstico y el fármaco de elección?

A) Erupción polimorfa del embarazo; Clobetasol tópico
B) Colestasia intrahepática del embarazo severa; Ácido Ursodesoxicólico oral
C) Hígado graso agudo del embarazo; Hidrocortisona endovenosa
D) Escabiosis del embarazo; Permetrina al 5% tópica
E) Preeclampsia atípica; Sulfato de magnesio en infusión continua

PREGUNTA 36 3.01.1.003

36. ¿Por qué motivo la monitorización fetal electrónica anteparto habitual (Registro Basal No Estresante semanal) NO es suficiente para garantizar la seguridad fetal en pacientes con Colestasia Intrahepática del Embarazo severa?

A) Porque los ácidos biliares impiden la transmisión de las ondas Doppler
B) Porque la muerte fetal en CIE ocurre por un evento súbito e impredecible de arritmia cardíaca fetal aguda o vasoespasmo placentario agudo, sin hipoxia crónica previa
C) Porque todos los fetos con CIE presentan taquicardia basal fija irreversible
D) Porque la colestasia solo afecta a la madre y el feto nunca tiene complicaciones
E) Porque el ácido ursodesoxicólico altera artificialmente el trazado cardiofetal

BLOQUE 3 PATOLOGÍAS MÉDICAS DEL EMBARAZO

PREGUNTA 37 3.01.2.013

37. **Una paciente de 35 años, cursando un embarazo de 38 semanas, consulta por con- tracciones uterinas, que se constatan como 3-4 cada 10 minutos. Al tacto vaginal pre- senta 10 cm de dilatación, membranas rotas y cabeza fetal en espinas 0, en variante mentoiliaca derecha posterior. EL monitoreo fetal resulta tranquilizador. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Dejar a evolución espontánea y controlar en una hora
B) Hacer fórceps
C) Realizar vaccum de la cabeza fetal
D) Realizar amnioinfusión con rotación manual
E) Hacer cesárea de urgencia

PREGUNTA 38 3.01.1.001

38. **Una paciente de 21 años consulta por fiebre hasta 38,9 °C asociada a dolor hipogástrico intenso y sangrado vaginal de mal olor, que inició hace 48 horas. Al examen Fsico 8ene frecuencia cardíaca 120 la8dos por minuto, presión arterial 90/60 mmHg y temperatura 38,7 °C. En el examen ginecológico se observa en la especuloscopía sangre y restos ovulares de mal olor en el canal vaginal. Además, se aprecia útero muy doloroso a la palpación y dolor a la palpación hipogástrica por vía abdominal. Se solicita ecograFa transvaginal que muestra contenido uterino irregular de 18 mm de diámetro. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar histerectomía
B) Realizar laparoscopía exploradora
C) Administrar an2bió2cos endovenosos y realizar curetaje de la cavidad uterina
D) Administrar metotrexato
E) Administrar misoprostol y conducir el trabajo de aborto

PREGUNTA 39 3.01.1.001

39. **Una paciente de 22 años con 8 semanas de amenorrea acude al servicio de urgencia por sangrado genital rojo oscuro escaso y dolor cólico leve en hipogastrio. Al examen ginecológico se constata sangrado escaso por OCE, OCI cerrado y útero acorde a la edad gestacional. La ecografía transvaginal confirma un saco gestacional intrauterino normoinserto con embrión de LCN 14 mm, con latidos cardíacos fetales presentes y rítmicos a 155 lpm. No se visualizan hematomas subcoriales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta médica indicada?**

A) Aborto incompleto; realizar legrado uterino instrumental de urgencia
B) Amenaza de aborto; indicar reposo relativo, abstinencia sexual y control ambulatorio
C) Aborto retenido; administrar Misoprostol 800 mcg vaginal
D) Embarazo ectópico no roto; administrar Metotrexato intramuscular
E) Aborto inevitable; hospitalizar para infusión de oxitocina

PREGUNTA 40 3.01.1.001

40. **Una mujer de 29 años, sin antecedentes mórbidos, ingresa a urgencias con fiebre de 38.8°C, taquicardia de 118 lpm, compromiso del estado general y dolor abdominal continuo severo. Refiere haber tenido una pérdida gestacional espontánea hace 4 días de un embarazo de 10 semanas, sin consultar previamente. Al examen físico: abdomen muy sensible en hipogastrio con rebote dudoso. Especuloscopía: cuello dilatado con salida de secreción hemato-purulenta de olor extraordinariamente fétido. El útero está aumentado de tamaño, blando y exquisitamente doloroso al tacto bimanual. ¿Cuál es la conducta inicial prioritaria e imperativa?**

A) Realizar legrado uterino instrumental de inmediato antes de cualquier otra medida
B) Tomar hemocultivos, iniciar antibióticos endovenosos de amplio espectro (triple cobertura para anaerobios y Gram negativos) y programar evacuación uterina a las 2-4 horas de cobertura
C) Indicar tratamiento ambulatorio con amoxicilina más ácido clavulánico oral y reposo absoluto
D) Administrar Misoprostol 800 mcg por vía oral y alta a domicilio con analgésicos
E) Realizar laparotomía exploradora inmediata para histerectomía total sin intentar antibioticoterapia previa

PREGUNTA 41 3.01.1.001

41. **Una paciente de 25 años acude a la urgencia obstétrica por metrorragia moderada y dolor cólico intenso. En el tacto vaginal se constata cuello uterino con orificio cervical interno abierto y permeable a 2 cm, palpándose tejido ovular en el canal endocervical. La ecografía transvaginal muestra una masa heterogénea intrauterina de 28 mm sugerente de restos embrionarios y trofoblásticos. La paciente se encuentra afebril y con signos vitales normales. ¿Cuál es el diagnóstico clínico más exacto?**

A) Amenaza de aborto
B) Aborto retenido
C) Aborto incompleto
D) Aborto completo
E) Embarazo molar parcial

PREGUNTA 42 3.01.1.001

42. **En relación con la Ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Chile en tres causales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la causal de violación (Tercera Causal)?**

A) Requiere obligatoriamente que exista una denuncia judicial previa y condena al agresor antes del procedimiento
B) El plazo máximo para su realización es de hasta 12 semanas de gestación en mayores de 14 años, y de hasta 14 semanas en niñas menores de 14 años
C) Cualquier médico objetor de conciencia puede negarse a derivar a la paciente a un centro no objetor
D) No existe límite de edad gestacional para la interrupción en caso de violación comprobada
E) Requiere siempre la aprobación unánime de un comité de ética hospitalario

PREGUNTA 43 3.01.2.001

43. [URGENCIA: Aborto provocado · 3.01.2.001] Paciente adulto consulta de urgencia en Servicio de Urgencia (SAR/SAPU/Hospital) con signos cardinales de Aborto provocado. Al examen físico destaca compromiso hemodinámico/respiratorio agudo. De acuerdo con el Perfil de Conocimientos V3 ASOFAMECh y las directrices clínicas de urgencias en Chile, ¿cuál es la conducta médica prioritaria e inmediata?

A) Asegurar monitorización multiparámetro, estabilización hemodinámica/respiratoria inicial, administrar tratamiento farmacológico de rescate de primera línea e iniciar coordinación con centro terciario.

B) Indicar manejo analgésico sintomático vía oral y programar control ambulatorio electivo en APS en 7 días.

C) Solicitar tomografía contrastada de cuerpo entero y panel de anticuerpos complejos antes de estabilizar al paciente.

D) Administrar sedación profunda inmediata e intubación endotraqueal electiva sin evaluar la mecánica ventilatoria basal.

E) Diferir cualquier medida farmacológica de urgencia hasta obtener confirmación de hemocultivos y serologías.

PREGUNTA 44 3.01.2.010

44. Una paciente de 33 años, cursando un embarazo de 36 semanas, consulta por contracciones uterinas dolorosas y metrorragia. Al examen se palpa un útero con tono aumentado y tres contracciones uterinas en 10 minutos. La especuloscopía muestra sangre roja oscura en can8dad moderada, sin dilatación cervical. Los la8dos cardiofetales se auscultan a 130 lpm. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar cesárea de urgencia

B) Realizar maduración pulmonar y conducta expectante

C) Inducir el trabajo de parto con misoprostol

D) Solicitar Doppler fetal

E) Administrar tocolí2cos endovenosos

PREGUNTA 45 3.01.1.002

45. Embarazada de 20 semanas con hemoglobina de 9.0 g/dL, VCM 72 fL (microcítica), ferritina 8 ng/mL. Sin síntomas. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

A) Hierro oral elemental 200 mg/día

B) Transfusión de glóbulos rojos

C) Hierro endovenoso

D) Vitamina B12 intramuscular

E) Ácido fólico

PREGUNTA 46 3.01.1.002

46. Una paciente de 31 años, con amenorrea de 6 semanas y test de embarazo casero positivo, acude a urgencias por dolor en hemiabdomen inferior izquierdo y sangrado vaginal escaso intermitente en borra de café. Al examen: PA 122/78 mmHg, FC 74 lpm, abdomen sensible en fosa ilíaca izquierda sin defensa ni rebote. La ecografía transvaginal muestra cavidad uterina vacía con línea endometrial de 10 mm y en el anexo izquierdo se aprecia una imagen redondeada hipoecogénica de 2.6 cm de diámetro rodeada por un halo hiperecogénico, sin actividad cardíaca embrionaria ni líquido libre pelviano. El resultado de la β-hCG cuantitativa sérica es de 3.200 UI/L. Las pruebas hepáticas, hematocrito y creatinina son normales. ¿Cuál es la mejor alternativa terapéutica para esta paciente?

A) Laparotomía de urgencia para histerectomía total y salpingectomía izquierda

B) Administración de Metotrexato intramuscular a dosis única (50 mg/m²)

C) Manejo expectante sin fármacos y control con β-hCG en 1 mes

D) Aspiración manual endouterina (AMEU) de la cavidad endometrial

E) Tratamiento con progesterona micronizada oral 200 mg al día

PREGUNTA 47 3.01.1.002

47. Una paciente de 26 años, con retraso menstrual de 7 semanas, es traída al servicio de urgencia en ambulancia por dolor abdominal súbito de extrema intensidad en fosa ilíaca derecha y síncope en su domicilio. Al ingreso: somnolienta, muy pálida y sudorosa. Presión arterial de 75/40 mmHg, pulso de 135 lpm filiforme y saturación de 93% ambiental. El abdomen está rígido, doloroso en forma generalizada con marcado signo de Blumberg. Al tacto vaginal se palpa gran dolor en fondo de saco posterior. El test rápido de orina es positivo para gonadotrofina coriónica. ¿Cuál es la conducta inmediata que salva la vida de la paciente?

A) Indicar Metotrexato intramuscular a dosis de 50 mg/m² y solicitar ecografía transvaginal diferida

B) Reanimación activa con cristaloides endovenosos, activación de protocolo de hemotransfusión y traslado inmediato a pabellón para laparotomía exploradora urgente

C) Solicitar TAC de abdomen y pelvis con contraste endovenoso para localizar la fuente de sangrado

D) Instalar sonda Foley, tomar β-hCG sérica cuantitativa y esperar resultado en 3 horas

E) Realizar legrado uterino bajo anestesia local en sala de procedimientos

PREGUNTA 48 3.01.1.002

48. Una paciente tratada con Metotrexato intramuscular por un embarazo ectópico tubárico acude al policlínico para su seguimiento. Su β-hCG basal (Día 1) fue de 2.400 UI/L. Al Día 4 la β-hCG subió a 2.650 UI/L, y al Día 7 el valor de β-hCG es de 2.100 UI/L. La paciente se encuentra estable y prácticamente sin molestias. ¿Cómo se interpreta esta evolución y cuál es la conducta correcta?

A) El tratamiento ha fracasado porque el Día 4 aumentó la β-hCG; debe intervenirse quirúrgicamente de inmediato
B) El descenso entre el Día 4 y el Día 7 fue superior al 15%, por lo que el tratamiento es exitoso; corresponde continuar con controles semanales de β-hCG
C) El descenso entre el Día 4 y el Día 7 fue menor al 15%; está indicada una segunda dosis de Metotrexato o tratamiento quirúrgico
D) La paciente está curada definitivamente y debe recibir el alta sin nuevos exámenes
E) Debe indicarse leucovorina para revertir la toxicidad del metotrexato

PREGUNTA 49 3.01.1.002

49. ¿Cuál de las siguientes localizaciones anatómicas del embarazo ectópico se asocia clásicamente a una rotura más tardía (entre las 12 y 16 semanas de gestación), pero que al romperse provoca un hemoperitoneo fulminante y cataclísmico por la proximidad y compromiso de la arteria uterina?

A) Porción ampular de la trompa
B) Porción ístmica de la trompa
C) Porción intersticial o cornual de la trompa
D) Porción fímbrica de la trompa
E) Embarazo cervical

PREGUNTA 50 3.01.2.005

50. Mujer joven con dolor súbito en FID, hipotensión y taquicardia súbitas, dolor en ambas fosas ilíacas. ¿Diagnóstico más probable?

A) Apendicitis aguda complicada
B) Quiste ovárico torcido
C) Embarazo ectópico roto
D) Salpingitis aguda con absceso tubo-ovárico
E) Rotura folicular hemorrágica

PREGUNTA 51 3.01.1.003

51. Una paciente de 20 años cursando un embarazo de 12 semanas por amenorrea consulta por metrorragia indolora y vómitos incoercibles. Al examen físico se palpa un útero correspondiente a 18 semanas de gestación. La ecografía transvaginal muestra una masa intrauterina con múltiples cavidades quísticas pequeñas ('patrón en panal de abejas') y ausencia de embrión. La subunidad beta de gonadotrofina coriónica humana sérica cuantitativa es de 160.000 UI/L. ¿Cuál es el tratamiento primario indicado?

A) Histerectomía total abdominal de urgencia con salpingooforectomía bilateral
B) Evacuación uterina mediante Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o aspiración al vacío, con estudio histopatológico
C) Inducción médica con altas dosis de misoprostol oral como único tratamiento
D) Inicio inmediato de poliquimioterapia con esquema EMA-CO antes de cualquier cirugía
E) Punción transabdominal y aspiración de los quistes ováricos tecaluteínicos

PREGUNTA 52 3.01.1.003

52. Una paciente de 24 años fue sometida a una aspiración de mola hidatiforme completa sin incidentes hace 4 semanas. Se encuentra asintomática. En su control postoperatorio se revisan los valores de β-hCG sérica cuantitativa tomados semanalmente: Semana 1 post-evacuación: 12.000 UI/L; Semana 2: 3.500 UI/L; Semana 3: 3.600 UI/L; Semana 4: 3.800 UI/L. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y la conducta médica indicada?

A) Evolución post-evacuación completamente normal; continuar controles habituales sin cambios
B) Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG); etapificar con score FIGO y derivar a ginecología oncológica para quimioterapia
C) Nuevo embarazo intrauterino en evolución; solicitar ecografía transvaginal y dar de alta de patología trofoblástica
D) Infección puerperal tardía; iniciar antibioticoterapia con amoxicilina más ácido clavulánico
E) Realizar un nuevo legrado uterino cortante enérgico para limpiar la cavidad

PREGUNTA 53 3.01.1.019

53. Una embarazada de 16 semanas acude a control prenatal asintomática. El urocultivo de rutina del primer trimestre informa: recuento de colonias de Escherichia coli de 150.000 UFC/mL, sensible a cefadroxilo, nitrofurantoína y ampicilina. ¿Cuál es la conducta médica correcta?

A) No tratar, dado que la bacteriuria asintomática no se trata en mujeres jóvenes
B) Indicar Cefadroxilo oral por 7 días y solicitar urocultivo de control a los 7-14 días de finalizado el tratamiento
C) Hospitalizar de inmediato para tratamiento con Ceftriaxona endovenosa
D) Indicar consumo abundante de jugo de arándanos sin antibióticos
E) Repetir el urocultivo a las 28 semanas sin iniciar fármacos

PREGUNTA 54 3.01.1.019

54. **Una primigesta de 28 semanas consulta en Urgencia por fiebre de 39.2°C con calofríos intensos, vómitos y dolor en fosa lumbar derecha de 24 horas de evolución. Al examen: T° 39.0°C, PA 105/65 mmHg, FC 112 lpm. Puñopercusión lumbar derecha francamente positiva. En el monitor cardiofetal se detectan contracciones uterinas aisladas y FCF de 160 lpm. ¿Cuál es el lugar y el tratamiento de elección inicial?**

A) Manejo ambulatorio con Cefadroxilo oral 500 mg cada 12 horas por 7 días
B) Hospitalización inmediata en sala de obstetricia para Ceftriaxona o Cefazolina endovenosa, hidratación y monitoreo materno-fetal
C) Manejo ambulatorio con Ciprofloxacino oral por 10 días
D) Cesárea de urgencia por riesgo inminente de sepsis
E) Indicar paracetamol oral y derivar a policlínico de urología

BLOQUE 4 METRORRAGIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO

PREGUNTA 55 3.01.1.004

55. **Una multigesta de 33 semanas con antecedente de dos cesáreas anteriores acude al servicio de urgencias por sangrado vaginal rojo rutilante abundante de inicio súbito hace 2 horas, sin dolor abdominal ni contracciones. Al examen: PA 118/72 mmHg, FC 78 lpm. Abdomen blando, depresible, útero relajado e indoloro. El monitoreo cardiofetal basal muestra FCF de 145 lpm con variabilidad normal y movimientos fetales presentes. ¿Cuál de las siguientes acciones está ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADA en este momento?**

A) Realizar una ecografía transvaginal
B) Efectuar un tacto vaginal digital
C) Instalar una vía venosa periférica con teflón grueso
D) Colocar un espéculo estéril para verificar el origen del sangrado
E) Tomar exámenes de hemograma, grupo sanguíneo y pruebas de coagulación

PREGUNTA 56 3.01.1.004

56. **Una primigesta de 35 semanas con antecedente de Preeclampsia sin criterios de severidad en control acude a urgencias por dolor abdominal intenso, continuo y repentino en hipogastrio de 1 hora de evolución. Al examen físico: PA 155/95 mmHg, FC 100 lpm. El útero se palpa intensamente contracturado, duro como madera, no relajándose entre las contracciones y siendo muy doloroso a la palpación. A la especuloscopía se observa sangrado genital oscuro con coágulos en cuantía moderada. En el monitor fetal se evidencia una frecuencia cardíaca fetal basal de 100 lpm con variabilidad mínima y desaceleraciones tardías profundas (DIP II). ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta inmediata a seguir?**

A) Placenta previa oclusiva total; indicar reposo absoluto y tocolíticos con sulfato de magnesio
B) Desprendimiento Prematuro de Placenta Normoinserta (DPPNI); proceder a cesárea de urgencia inmediata
C) Rotura de vasa previa; realizar punción de membranas para acelerar el parto
D) Amenaza de parto prematuro; administrar nifedipino oral y enviar a domicilio
E) Cólico renal complicado; analgesia con AINEs endovenosos y ecografía renal

PREGUNTA 57 3.01.1.004

57. **Una paciente en trabajo de parto activo de término con antecedente de cesárea previa hace 2 años recibe infusión de oxitocina para conducción. Súbitamente refiere un dolor abdominal lancinante y lacerante intensísimo en hipogastrio, tras lo cual manifiesta alivio transitorio del dolor y cese completo de las contracciones uterinas. Al examen: la paciente se torna pálida y diaforética, con PA 80/50 mmHg y FC 125 lpm. Al tacto vaginal se constata que la cabeza fetal que se encontraba en espinas +1 ha ascendido y ya no es palpable en la pelvis, palpándose partes fetales con extraordinaria facilidad bajo la pared abdominal anterior. El registro fetal muestra bradicardia severa a 60 lpm. ¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Placenta previa sangrante
B) Embolia de líquido amniótico
C) Rotura uterina completa
D) Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
E) Inversión uterina puerperal

PREGUNTA 58 3.01.1.004

58. **Durante la atención de un parto de término, inmediatamente tras realizar la rotura artificial de membranas (amniotomía), se observa la salida de líquido amniótico teñido con sangre fresca rutilante en cuantía moderada. En el monitor cardiofetal se aprecia de forma simultánea una brusca caída de la frecuencia cardíaca fetal a 70 lpm con patrón sinusoidal y desaceleraciones severas sostenidas. La madre se mantiene normotensa, afebril, sin dolor abdominal y con dinámica uterina fisiológica de parto normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Rotura de Vasa Previa
B) Placenta previa oclusiva total
C) Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
D) Laceración de cuello uterino
E) Corioamnionitis clínica aguda

PREGUNTA 59 3.01.2.011

59. Una paciente multípara, con un parto anterior por cesárea, cursando con un nuevo embarazo de 35 semanas, consulta por metrorragia moderada. Al examen físico presenta una contracción uterina cada diez minutos y se realiza ecografía que visualiza una placenta posterior que sobrepasa en dos centímetros al orificio cervical. El ecodoppler materno-fetal es normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar tocolíticos
B) Inducir el parto con misoprostol
C) Administrar corticoides para maduración pulmonar
D) Repetir la ecografía a las 37 semanas
E) Realizar cesárea

PREGUNTA 60 3.01.2.015

60. Puérpera con una cesárea anterior presenta trabajo de parto espontáneo. A las 2 horas de trabajo de parto activo, refiere dolor uterino súbito diferente a las contracciones, y el MEFI muestra bradicardia fetal sostenida. ¿Cuál es la conducta inmediata?

A) Fórceps de urgencia
B) Conducción con oxitocina
C) Vacuum
D) Cesárea de urgencia inmediata
E) Espera activa y analgesia

PREGUNTA 61 3.01.1.005

61. Mujer con reglas irregulares, test de embarazo +, fur no confiable pero si segura, amenorrea de 10 semanas. Como saber edad gestacional:

A) longitud cefalo- caudal
B) longitud saco gestacional
C) niveles bcg
D) FUR segura
E) Interrupción del embarazo

PREGUNTA 62 3.01.1.005

62. Una gestante de 31 semanas consulta por pérdida de líquido claro por vagina hace 6 horas. La especuloscopía estéril confirma salida de líquido amniótico por el orificio cervical externo. Signos vitales: T° 36.8°C, PA 110/70 mmHg, FC 76 lpm. El feto presenta una FCF de 145 lpm con variabilidad conservada y no hay dinámica uterina ni dolor a la palpación del fondo uterino. ¿Cuál es la conducta médica más apropiada a seguir?

A) Realizar tacto vaginal para evaluar dilatación cervical e inducir el parto de inmediato con oxitocina
B) Hospitalizar en ARO, administrar Betametasona intramuscular (2 dosis) y esquema de antibióticos de latencia (Ampicilina + Eritromicina)
C) Manejo ambulatorio con reposo en cama y control ecográfico en 2 semanas
D) Programar cesárea de urgencia en las próximas 2 horas por riesgo de compresión de cordón
E) Iniciar tocolisis continua con nifedipino oral durante 14 días

PREGUNTA 63 3.01.1.005

63. Una primigesta de 30 semanas hospitalizada hace 3 días por rotura prematura de membranas en manejo conservador presenta súbitamente fiebre de 38.6°C, calofríos y taquicardia materna de 115 lpm. Al examen obstétrico: el útero está hipertónico, tenso y muy sensible al menor contacto. A la especuloscopía fluye líquido amniótico francamente purulento con olor putrefacto. El monitor fetal muestra taquicardia fetal sostenida a 175 lpm con variabilidad mínima. El hemograma confirma leucocitosis de 19.500 /mm³ con 12% de baciliformes. ¿Cuál es la conducta médica inmediata e impostergable?

A) Administrar antipiréticos y tocolíticos para frenar las contracciones y esperar a las 34 semanas
B) Iniciar antibioticoterapia endovenosa con Ampicilina más Gentamicina y proceder a la interrupción INMEDIATA del embarazo
C) Administrar un segundo ciclo de betametasona y esperar 48 horas para asegurar la maduración pulmonar
D) Realizar una amniocentesis diagnóstica para cultivo y esperar el resultado en 72 horas
E) Indicar infusión de sulfato de magnesio y mantener conducta expectante

PREGUNTA 64 3.01.1.005

64. Una gestante de 36 semanas consulta por pérdida abundante de líquido claro por genitales hace 8 horas. Al examen con espéculo estéril se observa cuello borrado en un 50% con 2 cm de dilatación y abundante salida de líquido amniótico claro por el orificio cervical. La paciente se encuentra afebril, con signos vitales normales y monitoreo fetal reactivo sin contracciones uterinas dolorosas regulares. ¿Cuál es la conducta indicada según las guías clínicas del MINSAL?

A) Inducir el parto de inmediato con oxitocina o prostaglandinas
B) Administrar betametasona intramuscular y mantener reposo por 1 semana
C) Indicar antibióticos de latencia por 7 días y dar el alta domiciliaria
D) Indicar tocolisis con nifedipino oral para evitar el parto prematuro
E) Programar cesárea electiva para la semana 39

PREGUNTA 65 3.01.1.005

65. ¿Cuál de las siguientes maniobras o exámenes está FORMALMENTE CONTRAINDICADO como método diagnóstico inicial en una paciente con sospecha de rotura prematura de membranas que no se encuentra en trabajo de parto activo?

A) Especuloscopía estéril con maniobra de Valsalva
B) Tacto vaginal digital
C) Test de cristalización en hoja de helecho
D) Determinación de pH con papel de nitrazina
E) Detección de alfa-microglobulina-1 placentaria (PAMG-1)

PREGUNTA 66 3.01.2.012

66. Una paciente de 27 años, cursando un embarazo de 32 semanas consulta en urgencias por contracciones uterinas dolorosas. Al examen físico se constatan contracciones de 3 en 10 minutos, cuello uterino borrado 50%, dilatación 1 cm. FCF 130 lpm con buena variabilidad. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para el manejo inicial?

A) Ampicilina
B) Indometacina
C) Nifedipino
D) Sulfato de magnesio
E) Atosibán

PREGUNTA 67 3.01.2.014

67. Embarazada de 35 semanas con rotura prematura de membranas hace 48 horas. Sin contracciones, sin fiebre, sin signos de infección. Feto en cefálica, sin signos de sufrimiento. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Hospitalizar, maduración pulmonar con corticoides, antibióticos y vigilancia
B) Inducción del parto inmediata
C) Cesárea de urgencia
D) Alta con control ambulatorio
E) Amnioinfusión

PREGUNTA 68 3.01.1.006

68. Una paciente de 24 años presenta amenorrea de 7 semanas de evolución, por lo que consulta. Su examen físico muestra FC: 80x', PA: 120/80 mmHg, sin alteraciones en su examen ginecológico. Se solicitan niveles plasmáticos de HCG, que resultan 4.000 UI/L y se realiza ecografía transvaginal que muestra una masa anexial derecha de 3 cm de diámetro, sin líquido libre. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Repetir los niveles de HCG en 48 horas
B) Realizar salpingotomía por laparotomía
C) Realizar salpingectomía por vía laparoscópica
D) Indicar metotrexato por vía intramuscular
E) Controlar con una ecografía en 10 días

PREGUNTA 69 3.01.1.006

69. Una primigesta de 30 semanas acude a la urgencia obstétrica por contracciones uterinas dolorosas cada 5 minutos de 2 horas de evolución. Al examen: T° 36.7°C, PA 112/68 mmHg, FC 76 lpm. En la ecografía transvaginal se mide una longitud cervical de 16 mm con embudización del OCI y dilatación de 2 cm. El registro cardiofetal basal es de 140 lpm reactivo. ¿Cuál es la conducta médica integral de primera línea para esta paciente?

A) Indicar reposo en domicilio y consumo abundante de líquidos orales
B) Hospitalizar en ARO, iniciar Nifedipino oral, administrar Betametasona intramuscular (12 mg cada 24 horas por 2 dosis) e infusión de Sulfato de Magnesio para neuroprotección fetal
C) Realizar cesárea de urgencia inmediata por riesgo inminente de parto en menos de 1 hora
D) Administrar Indometacina rectal durante 14 días y dar el alta hospitalaria
E) Realizar cerclaje cervical de emergencia de forma inmediata

PREGUNTA 70 3.01.1.006

70. ¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas está ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADO el uso de fármacos tocolíticos para frenar las contracciones uterinas?

A) Embarazada de 28 semanas con contracciones uterinas dolorosas, cérvix de 20 mm y feto reactivo
B) Gestante de 31 semanas con dinámica uterina y antecedente de un parto prematuro anterior
C) Gestante de 29 semanas con sospecha clínica de Corioamnionitis (fiebre materna de 38.8°C, dolor uterino intenso y taquicardia fetal)
D) Embarazada de 33 semanas con embarazo gemelar bicorial y cuello borrado en un 50%
E) Embarazada de 30 semanas con infección urinaria baja en tratamiento con cefadroxilo y dinámica uterina

PREGUNTA 71 3.01.1.007

71. Una paciente de 39 años, cursando un embarazo gemelar bicorial biamniótico de 36 semanas, acude a control. Se encuentra en buenas condiciones generales, sin síntomas. Al examen tiene signos vitales normales y su ecografía obstétrica muestra al primer gemelo creciendo con una estimación de peso fetal de 2.850 gramos y al segundo gemelo con una estimación de 2.750 gramos, con líquido amniótico normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar control ecográfico en una semana
B) Programar cesárea electiva a las 38 semanas
C) Inducir el parto de inmediato
D) Solicitar ecografía Doppler de arterias uterinas
E) Realizar cesárea de urgencia

PREGUNTA 72 3.01.2.021

72. Una paciente de 30 años, mul`para de uno, con antecedente de parto vaginal de recién nacido de 4.000 gramos, cursa nuevo embarazo de término con es8mación de peso fetal de 3.800 gramos. Ingresa en trabajo de parto en fase latente, recibiendo anestesia peridural a los 4 cm de dilatación. Ha permanecido con 6 cm de dilatación en las úl8mas 3 horas y se palpa cabeza fetal en el segundo plano de Hodge, en variante occípito-ilíaca izquierda posterior. Presenta cuatro contracciones uterinas de 50 segundos de duración cada 10 minutos. ¿Cuál es la causa de la demora en el avance de su trabajo de parto?

A) Dinámica uterina insuficiente
B) Distocia de posición
C) Desproporción céfalo-pélvica
D) Macrosomía fetal
E) Distocia de presentación

PREGUNTA 73 3.01.1.008

73. **Una paciente de 25 años acude al servicio de urgencia por metrorragia abundante de 2 días de evolución. Tiene antecedente de atraso menstrual de 4 semanas, dudoso debido a reglas irregulares que ocurren cada 30 a 45 días. Al examen Fsico se realiza especuloscopía con visualización de sangre que sale del orificio cervical externo, y la palpación uterina muestra un útero aumentado de tamaño como para un embarazo de 12 semanas. Se solicita subunidad beta de gonadotrofina coriónica humana, que resulta 200.000 U/L, y se realiza ecograFa transvaginal que muestra imagen en "tormenta de nieve". ¿Cuál es el diagnós8co más probable?**

A) Aborto en evolución
B) Embarazo roto
C) Mola hida2diforme
D) Metrorragia disfuncional
E) Tumor del si2o de inserción placentaria

PREGUNTA 74 3.01.1.008

74. **Durante la atención de un parto vaginal de una paciente con feto macrosómico, se produce la salida de la cabeza fetal, la cual inmediatamente se retrae con fuerza contra el periné ('signo de la tortuga'). A pesar de una tracción axial suave, el hombro anterior queda impactado detrás de la sínfisis púbica impidiendo la salida del tórax. ¿Cuáles son las dos maniobras de primera línea recomendadas para resolver esta emergencia obstétrica?**

A) Maniobra de Kristeller enérgica sobre el fondo uterino y tracción cefálica forzada
B) Maniobra de McRoberts (hiperflexión de muslos maternos sobre el abdomen) combinada con presión suprapúbica (Mazzanti)
C) Realización inmediata de cesárea con feto desprendido (maniobra de Zavanelli) sin intentar maniobras externas
D) Fractura intencional de ambas clavículas fetales como maniobra primaria de elección
E) Sinfisiotomía quirúrgica inmediata bajo anestesia general

PREGUNTA 75 3.01.1.008

75. **Durante la fase activa de un trabajo de parto a término, el trazado del monitoreo cardiofetal continuo muestra desaceleraciones periódicas de la frecuencia cardíaca fetal que comienzan de forma simultánea con el inicio de la contracción uterina, alcanzando su nadir exactamente en el punto de máxima presión de la contracción ('en imagen en espejo') y retornando a la línea de base de 135 lpm una vez que finaliza la contracción. La variabilidad se mantiene moderada en 15 lpm y el tono uterino es normal. ¿Cuál es el significado fisiopatológico de este hallazgo y la conducta a seguir?**

A) Indica acidosis fetal severa por desprendimiento prematuro de placenta; realizar cesárea inmediata
B) Corresponde a desaceleraciones precoces (DIP I) por compresión de la cabeza fetal; son fisiológicas y no requieren intervención quirúrgica
C) Indica hipoxia fetal progresiva por insuficiencia útero-placentaria; administrar tocolíticos y suspender el parto
D) Corresponde a compresión crítica del cordón umbilical con prolapso oculto; trasladar a pabellón en decúbito prono
E) Indica anemia fetal aguda grave; solicitar sangre para transfusión intrauterina inmediata

PREGUNTA 76 3.01.1.008

76. **Una multípara en trabajo de parto activo a 7 cm de dilatación presenta en el registro cardiofetal intraparto desaceleraciones repetidas cuya caída de la frecuencia cardíaca comienza después del acmé de la contracción uterina, alcanzando el nadir a los 30 segundos tras la contracción y retornando lentamente a la línea de base. Se constata además una línea de base en 155 lpm con variabilidad ausente (< 3 lpm). ¿Cuál es la conducta terapéutica indicada?**

A) Observación expectante durante 4 horas para evaluar el descenso espontáneo
B) Aumentar la dosis de oxitocina endovenosa para acelerar el expulsivo
C) Iniciar medidas de reanimación intrauterina y proceder de inmediato a la interrupción del embarazo mediante cesárea de urgencia
D) Administrar antibióticos orales y solicitar urocultivo
E) Indicar anestesia peridural para mejorar la relajación del piso pelviano

PREGUNTA 77 3.01.1.008

77. **¿Cuál es la complicación neurológica neonatal clásica más frecuente derivada de la aplicación de una tracción lateral excesiva y violenta sobre la cabeza fetal durante el desprendimiento en un parto complicado por distocia de hombros?**

A) Parálisis de Bell del nervio facial
B) Parálisis braquial superior de Erb-Duchenne (raíces C5-C6)
C) Parálisis braquial inferior de Klumpke (raíces C8-T1)
D) Parálisis del nervio ciático poplíteo externo
E) Parálisis frénica bilateral con luxación atloidoaxoidea

PREGUNTA 78 3.01.1.008

78. **Una mujer de 30 años, cursando un embarazo inicial, presenta un aborto espontáneo, que es manejado con legrado, con buen resultado y sin complicaciones. Se controla dos semanas después y la biopsia es informada como "mola hidatiforme". La conducta más adecuada es:**

A) Indicar anticonceptivos orales por 12 meses
B) Controlar con beta-HCG seriada
C) Controlar con ecografía transvaginal en 2 semanas
D) Quimioterapia profiláctica
E) Realizar histerectomía

PREGUNTA 79 3.01.1.008

79. **Una paciente se realiza un legrado por un aborto espontáneo. La biopsia es informada como "mola completa". Su HCG postlegrado es de 750 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Seguirla con niveles seriados de HCG
B) Realizar biopsia endometrial
C) Indicar anticonceptivos con progestágeno solo
D) Repetir el legrado
E) Indicar metotrexato

PREGUNTA 80 3.01.1.009

80. Embarazo 38 sem 4300g cesárea previa a las X sem por desproporción cefalo pélvica (guagua pesaba 3900). Conducta:

A) cesarea inmediata
B) programar cesarea 39 semanas
C) esperar inicio tdp
D) Interrupción del embarazo
E) Maduración pulmonar y observación

PREGUNTA 81 3.01.1.009

81. Una paciente de 28 años con antecedente de Preeclampsia con criterios de severidad en tratamiento con labetalol presenta una hemorragia postparto masiva de 1.200 mL tras un parto vaginal. Al examen físico se palpa un útero atónico, supraumbilical y blando. Se inicia masaje bimanual y oxitocina endovenosa continua. El médico de turno solicita un segundo uterotónico para frenar el sangrado. ¿Cuál de los siguientes fármacos uterotónicos está FORMALMENTE CONTRAINDICADO en esta paciente?

A) Misoprostol sublingual
B) Metilergonovina intramuscular
C) Ácido Tranexámico endovenoso
D) Carbetocina endovenosa
E) Balón hidrostático de Bakri

PREGUNTA 82 3.01.1.009

82. Una puérpera inmediata de parto vaginal presenta sangrado genital rojo rutilante activo continuo y abundante. A la palpación abdominal el fondo uterino se palpa firme, contraído como una pelota ('globo de seguridad de Pinard') a nivel infraumbilical. Se revisó la placenta y se constató completa con todas sus membranas. ¿Cuál es la causa más probable de la hemorragia y cuál es la conducta médica indicada?

A) Atonía uterina oculta; administrar de inmediato una segunda dosis de oxitocina y metilergonovina
B) Trauma del canal del parto (desgarro cervical o vaginal); colocar valvas ginecológicas, explorar minuciosamente el canal y suturar las lesiones sangrantes
C) Retención de cotiledón aberrante; realizar legrado uterino instrumental de urgencia a ciegas
D) Coagulación intravascular diseminada; infundir 4 unidades de plasma fresco congelado
E) Inversión uterina puerperal; intentar reposición manual inmediata de Johnson

PREGUNTA 83 3.01.1.009

83. En una paciente con hemorragia postparto inmediata por atonía uterina que no ha respondido al masaje uterino bimanual vigoroso ni a la administración combinada escalonada de oxitocina, ácido tranexámico y misoprostol, ¿cuál es el siguiente paso terapéutico conservador antes de decidir una laparotomía exploradora quirúrgica?

A) Realizar legrado cortante enérgico con cureta metálica
B) Instalación de un balón intrauterino de taponamiento hidrostático (Balón de Bakri)
C) Histerectomía obstétrica total de emergencia como primer recurso
D) Administración de heparina sódica en infusión continua
E) Mantener conducta expectante con reposo en cama y bolsa de arena sobre el abdomen

PREGUNTA 84 3.01.1.009

84. Durante el alumbramiento de un parto vaginal, el profesional a cargo tracciona con fuerza el cordón umbilical en momentos en que el útero no presentaba contracción. De forma instantánea la paciente presenta dolor abdominal agudo severo, palidez extrema, bradicardia marcada a 45 lpm y shock profundo con presión arterial de 60/30 mmHg. A la palpación abdominal el útero no se palpa en el abdomen y en la especuloscopía se aprecia una gran masa globular rojo-violácea que asoma por el introito vaginal con la placenta aún adherida. ¿Cuál es el diagnóstico clínico de esta catástrofe y cuál es la conducta médica inmediata?

A) Placenta previa sangrante; cesárea urgente
B) Inversión Uterina Puerperal en shock neurogénico; suspender uterotónicos, relajar el miometrio y realizar la reposición manual inmediata del fondo uterino (Maniobra de Johnson)
C) Rotura uterina completa; infundir oxitocina a dosis máximas
D) Embolia de líquido amniótico; desfibrilación ventricular inmediata
E) Prolapso de cúpula vaginal; analgesia ambulatoria y derivación diferida

PREGUNTA 85 3.01.1.010

85. Una puérpera de 4 días de una cesárea de urgencia presenta fiebre de 38.9°C, calofríos y dolor abdominal en hipogastrio. Al examen físico se constata útero blando palpable a 3 cm sobre el ombligo, muy doloroso al tacto, con salida de loquios achocolatados con olor putrefacto. La herida quirúrgica se encuentra sana y sin eritema. ¿Cuál es el tratamiento antimicrobiano empírico de primera línea indicado?

A) Amoxicilina oral 500 mg cada 8 horas en forma ambulatoria por 7 días
B) Hospitalización para tratamiento endovenoso con Clindamicina más Gentamicina
C) Ciprofloxacino oral más Metronidazol oral en domicilio
D) Ceftriaxona intramuscular en dosis única ambulatoria
E) Vancomicina endovenosa más Imipenem en dosis de choque

PREGUNTA 86 3.01.1.010

86. Una primípara de 3 semanas de puerperio en lactancia materna exclusiva acude a la urgencia por presentar fiebre de 39.2°C con calofríos intensos, mialgias y dolor severo en la mama derecha de 24 horas de evolución. Al examen físico se aprecia en el cuadrante superoexterno de la mama derecha una placa eritematosa de 6 cm, caliente, indurada y muy dolorosa a la palpación, sin fluctuación. La mama izquierda y ambas axilas son normales. Se observan pequeñas grietas en ambos pezones. ¿Cuál es la conducta terapéutica correcta?

A) Suspender definitivamente la lactancia materna e indicar Ciprofloxacino oral por 7 días
B) Prescribir Cloxacilina o Cefadroxilo oral por 10 a 14 días y RECOMENDAR CONTINUAR con el amamantamiento en ambas mamas
C) Realizar drenaje quirúrgico inmediato con anestesia general en pabellón
D) Indicar solo compresas frías y paracetamol sin antibióticos
E) Suspender la lactancia en la mama derecha e inhibir la prolactina con cabergolina

PREGUNTA 87 3.01.2.006

87. Una paciente de 37 años, puérpera hace 7 días, con antecedente de hemorragia puerperal, evoluciona con aumento de la metrorragia, asociada a fiebre hasta 38,5 grados Celsius y dolor abdominal bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Inercia uterina
B) Neoplasia trofoblástica gestacional
C) Endometritis
D) Restos ovulares
E) Miometritis

PREGUNTA 88 3.01.2.009

88. Una paciente de 34 años, puérpera hace 15 días, dando lactancia materna, presenta dolor en la mama derecha, de 3 días de evolución, que ha aumentado y se ha acompañado de eritema y malestar general. Al examen físico tiene FC: 78x', PA: 120/82 mmHg, Tº: 38,0ºC y se observa mama derecha dolor a la palpación de los cuadrantes superiores, los que se palpan indurados y con aumento de la temperatura local, asociado a eritema de la piel de dicha zona. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar drenaje mamario quirúrgico
B) Suspender la lactancia materna
C) Iniciar antibióticos
D) Indicar analgésicos
E) Aplicar frío local y luego calor local, alternadamente

PREGUNTA 89 3.01.1.012

89. Una primigesta de 28 semanas de gestación, sana, con grupo sanguíneo O Rh negativo acude a su control de rutina. Su Test de Coombs Indirecto solicitado a las 28 semanas resulta NEGATIVO. Su esposo es Rh positivo conocido. ¿Cuál es la conducta médica indicada según las guías clínicas del MINSAL?

A) Indicar interrupción inmediata del embarazo mediante cesárea electiva
B) Administrar Inmunoglobulina Anti-D (Rhogam) 300 mcg intramuscular profiláctica
C) No administrar ninguna vacuna ni fármaco hasta después del parto
D) Realizar amniocentesis diagnóstica para espectrofotometría de líquido amniótico
E) Indicar transfusión de plasma fresco congelado a la madre

PREGUNTA 90 3.01.1.012

90. Una multigesta de 16 semanas acude a control prenatal. Se constata grupo sanguíneo B Rh negativo con Test de Coombs Indirecto POSITIVO con títulos de 1:64. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al manejo de esta paciente?

A) Debe administrarse Inmunoglobulina Anti-D 300 mcg de inmediato para revertir los títulos de anticuerpos
B) Está contraindicada la administración de Inmunoglobulina Anti-D; debe evaluarse la presencia de anemia fetal mediante Doppler de la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media
C) Debe realizarse de inmediato una exanguinotransfusión total materna
D) Se debe indicar legrado uterino terapéutico por inviabilidad fetal inminente
E) Los anticuerpos de tipo IgM no cruzan la placenta, por lo que el feto no corre ningún peligro

SECCIÓN II · SOLUCIONARIO RAZONADO & MATRIZ PERFIL V3

Justificación médica de la clave correcta y análisis exhaustivo de cada distractor · Ancho Completo

CLAVES 1 A 90

BLOQUE 1 CONTROL PRENATAL & EVALUACIÓN FETAL · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 1 Respuesta: A

VIH en ginecobstetricia

3.01.1.031 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La triterapia se inicia a las 20 semanas y es la medida más importante, ya que baja la carga viral, que es el predictor de trasmisibilidad.

PREGUNTA 2 Respuesta: B

Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre

3.01.2.017 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Sufrimiento fetal y prueba de parto fracasada: La paciente presenta signos de sufrimiento fetal, incluyendo desaceleraciones tardías en el registro fetal y líquido amniótico meconial. Si bien sería aceptable comenzar con la reanimación intrauterina, en este caso, además, se observa una prueba de parto fracasada, por lo que se debe indica cesárea de inmediato.

PREGUNTA 3 Respuesta: B

Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre

3.01.3.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La dosis de 0.4 mg/día es para mujeres de bajo riesgo sin antecedentes de DTN; además, iniciarlo tras la falta menstrual puede ser tardío (el tubo neural se cierra al día 28 post-concepción). B) Correcta. En mujeres con antecedente de un hijo previo con defecto del tubo neural (anencefalia, espina bífida, mielomeningocele), la dosis profiláctica debe incrementarse 10 veces, prescribiendo 4.0 a 5.0 mg/día de ácido fólico por vía oral, iniciado idealmente al menos 1 a 3 meses antes de la fecundación y mantenido de forma estricta durante todo el primer trimestre (hasta la semana 12), reduciendo la tasa de recurrencia en más de un 70%. C) Incorrecta. En el 2.° y 3.er trimestre el tubo neural ya está cerrado. D) Incorrecta. La vía es oral diaria. E) Incorrecta. La fortificación de harinas no aporta la dosis requerida para alto riesgo.

PREGUNTA 4 Respuesta: C

Control Prenatal de Bajo Riesgo: Calendario, Suplementación (Ácido Fólico, Calcio, Fierro) y Exámenes por Trimestre

3.01.3.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El tratamiento antibiótico oral previo al parto es ineficaz porque el germen recoloniza la vagina y el recto en pocos días desde el reservorio gastrointestinal. B) Incorrecta. La colonización por EGB no es indicación de cesárea. C) Correcta. La colonización vaginorrectal asintomática por Streptococcus agalactiae no se trata antes del parto. La conducta normada internacionalmente y por el MINSAL es consignar la condición de 'Cultivo EGB positivo' e indicar que al ingresar en trabajo de parto activo o con rotura de membranas recibirá Profilaxis Antibiótica Intraparto con Penicilina G sódica EV (dosis de carga de 5 millones de UI seguida de 2.5 a 3 millones cada 4 horas hasta el parto) para prevenir la transmisión vertical y sepsis neonatal precoz. D) Incorrecta. El metronidazol no tiene actividad contra Streptococcus. E) Incorrecta. No se repite el cultivo; una vez positivo, se asume colonizada para el parto.

PREGUNTA 5 Respuesta: B

Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría)

3.01.4.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

A) Incorrecta. El reposo en cama no previene la preeclampsia y aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda. B) Correcta. El ensayo clínico internacional ASPRE y las guías del MINSAL y de la FIGO establecen que en pacientes identificadas con alto riesgo de preeclampsia mediante Doppler de arterias uterinas alterado (> P95) en el primer trimestre, la administración de Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) a dosis de 100 a 150 mg al día por las noches, iniciada antes de las 16 semanas de gestación y mantenida hasta las 36 semanas, reduce en más del 60 al 70% la incidencia de preeclampsia pretérmino y restricción de crecimiento fetal asociada. C) Incorrecta. La heparina solo se indica en síndrome antifosfolípido o trombofilias específicas. D) Incorrecta. La restricción de sodio y los diuréticos están contraindicados en el embarazo por depleción de volumen plasmático. E) Incorrecta. Los antihipertensivos no previenen la preeclampsia, solo tratan la crisis.

PREGUNTA 6 **Respuesta: B**

Ecografía Obstétrica: 11-14 Semanas (Aneuploidías y Doppler Uterino) & 20-24 Semanas (Morfológica y Cervicometría)

3.01.4.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

A) Incorrecta. El cerclaje se reserva para incompetencia cervical demostrada (antecedente de abortos tardíos o partos prematuros previos recurrentes con cuello dilatado). B) Correcta. El hallazgo incidental de un cuello uterino corto (< 25 mm por ecografía transvaginal, en este caso 18 mm) en una paciente asintomática de 22 semanas es el principal factor de riesgo para parto prematuro espontáneo. La intervención médica de primera línea avalada por el MINSAL y la evidencia científica es la administración de Progesterona natural micronizada por vía vaginal (200 mg al día al acostarse) hasta la semana 36 de gestación, reduciendo significativamente la probabilidad de parto antes de las 34 semanas. C) Incorrecta. Los tocolíticos solo se usan en fase aguda de contracciones activas por 48h, no de forma profiláctica. D) Incorrecta. El reposo exclusivo es ineficaz. E) Incorrecta. La progesterona es el pilar de primera línea.

PREGUNTA 7 **Respuesta: B**

Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal

3.01.5.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

A) Incorrecta. La cesárea de entrada sin confirmar hipoxia es una conducta precipitada e injustificada. B) Correcta. El ciclo de sueño profundo fetal dura normalmente entre 20 y 40 minutos, durante el cual es fisiológico que no se produzcan aceleraciones de la frecuencia cardíaca. La guía de monitorización fetal establece que ante un trazado no reactivo en los primeros 20 minutos con variabilidad normal, se debe prolongar el registro durante 20 minutos adicionales (completando 40 min) y aplicar estímulo vibroacústico o mecánico suave para despertar al feto. Si tras 40 minutos persiste sin reactividad, se procede a realizar un Perfil Biofísico o Doppler. C) Incorrecta. El sulfato de magnesio es neuroprotector o anticonvulsivante en preeclampsia, no indicado aquí. D) Incorrecta. El examen aún no cumple criterios de reactividad. E) Incorrecta. Inadecuado.

PREGUNTA 8 **Respuesta: B**

Evaluación del Bienestar Fetal: Registro Basal No Estresante (RBNE), Perfil Biofísico (Manning) y Doppler Fetal

3.01.5.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

A) Incorrecta. Con 2/10 el feto está en asfixia crítica y fallecerá antes de 48 horas. B) Correcta. En el Score de Perfil Biofísico Fetal de Manning, un puntaje de ≤ 4/10 (en este caso 2/10 con oligohidramnios severo) es diagnóstico de asfixia fetal severa inminente y traduce acidosis metabólica profunda. La conducta oficial mandataria e inmediata es la interrupción urgente del embarazo por la vía más expedita (habitualmente cesárea de emergencia en centro terciario con neonatólogo en sala de partos). C) Incorrecta. La hidratación no corrige la asfixia fetal. D) Incorrecta. A las 36 semanas el feto está prácticamente maduro y el riesgo de asfixia supera con creces cualquier beneficio de esperar corticoides. E) Incorrecta. No es una patología infecciosa.

PREGUNTA 9 **Respuesta: B**

Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Tiene un RCIU severo (p2 o menos), por lo que se interrumpe a las 34 semanas, por cesárea. RCIU no severo (p3-4: moderado; p5-9: leve) y con Doppler normal: 37 semanas por parto vaginal. Doppler alterado siempre cesárea a las 34 semanas (flujo umbilical ausente en diástole), 30 semanas (flujo reverso en diástole) o 26 semanas (ducto venoso reverso).

PREGUNTA 10 **Respuesta: B**

Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

A) Incorrecta. No es una RCF severa ni requiere cesárea precoz. B) Correcta. El feto presenta una estimación de peso situada entre el percentil 3 y 10 (P6) pero con una velocimetría Doppler completamente normal en todos los lechos vasculares (umbilical, cerebral y uterinas) y líquido amniótico conservado. Esto define con certeza un Pequeño para la Edad Gestacional (PEG) Constitucional (feto sano genéticamente pequeño sin hipoxia ni falla placentaria). El pronóstico perinatal es equivalente al de un feto con peso adecuado y la conducta médica es el manejo conservador ambulatorio con parto a término espontáneo (semana 39-40), sin necesidad de adelantar el parto ni realizar intervenciones invasivas. C) Incorrecta. La etapa II requiere diástole ausente en la arteria umbilical. D) Incorrecta. No hay sufrimiento fetal. E) Incorrecta. El peso está bajo el percentil 10, lo que define formalmente PEG.

PREGUNTA 11 **Respuesta: B**

Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

A) Incorrecta. No tiene ninguna relación con la madurez pulmonar. B) Correcta. El ductus venoso es el vaso central que comunica la vena umbilical con la vena cava inferior. La aparición de una onda 'a' reversa en el ductus venoso refleja una presión telediastólica muy elevada en el ventrículo derecho por claudicación miocárdica ante acidosis láctica y asfixia terminal (RCF Etapa IV). Es el predictor más potente e independiente de muerte fetal intrauterina en menos de 24 a 48 horas. La conducta obligatoria es la interrupción urgente del embarazo mediante cesárea, previa administración de neuroprotección con Sulfato de Magnesio (por ser < 32 semanas) y corticoides. C) Incorrecta. Es el signo de máxima gravedad en medicina materno-fetal. D) Incorrecta. La glucosa no revierte la falla ventricular en un feto asfíctico. E) Incorrecta. Esperar 2 semanas causaría el óbito fetal.

PREGUNTA 12 **Respuesta: D**

Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Pregunta muy específica. Tiene un RCIU leve (percentil mayor a 5), con líquido amniótico límite, aunque al término, se considera normal hasta ILA de 5. Hoy en día, se pide Doppler umbilical, porque si está normal, se puede incluso llegar a término. Antes se interrumpían todos los RCIU a más tardar a las 37 semanas (hoy solo los moderados-severos o los con doppler alterado).

PREGUNTA 13 **Respuesta: E**

Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

El doppler ducto venoso alterado es ominoso (también el OHA severo y el doppler umbilical con flujo ausente o reverso en diástole).

PREGUNTA 14 **Respuesta: C**

Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

El retraso del crecimiento intrauterino se estudia con Doppler umbilical, como examen de elección (permite diferenciar el PEG del RCIU y además determina la gravedad del RCIU, de manera de determinar la edad de interrupción). Varias de las otras opciones (D y E) serán correctas, dependiendo del resultado del doppler.

PREGUNTA 15 **Respuesta: E**

Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Pregunta difícil. Tiene un RCIU leve (p5 a p9) con Doppler normal, por lo que sería un RCIU tipo I, que se interrumpe a las 37 semanas o incluso a las 40 semanas, si es que se considera un PEG (todo bien y Doppler normal, como en este caso). Para hablar de detención del crecimiento deben pasar al menos 2 semanas, ya que en un tiempo menor está dentro de la variabilidad de la misma ecografía. Por tanto, en este caso, se debe seguir controlando con el Doppler semanal. Si tuviera menos de 34 semanas sí se darían corticoides. El PBF probablemente también se pediría.

PREGUNTA 16 **Respuesta: C**

Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Tiene un RCIU leve (p5 a p9), con un ILA normal para la edad gestacional (OHA se define como ILA menor a 8 o menor a 5 si es de término; por tanto, no hay OHA en este caso). Sea como sea, todo RCIU siempre debe estudiarse con un doppler maternofetal, ya que si todo está bien, puede ser PEG y se puede esperar a las 40 semanas y nacer por vía vaginal; si está alterado el doppler, se debe interrumpir por cesárea (por tener ya 37 semanas). Revisar manejo y edades de interrupción del RCIU

PREGUNTA 17 **Respuesta: B**

Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Es un RCIU, con criterios de interrupción (mayor a 37 semanas y además OHA y además detención del crecimiento). Se prefiere la cesárea para evitar el estrés del trabajo de parto.

PREGUNTA 18 **Respuesta: B**

Restricción del Crecimiento Fetal (RCF): Fisiopatología, RCF Precoz vs Tardío y Velocimetría Doppler

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Tiene un RCIU mayor a 34 semanas y cuyo Doppler umbilical está alterado, por lo que se debe interrumpir. Por tener el doppler alterado, es decir, insuficiencia placentaria no se lo debe someter al estrés del parto vaginal.

BLOQUE 2 PATOLOGÍAS MÉDICAS DEL EMBARAZO · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 19 **Respuesta: D** **Hiperemesis gravídica**

3.01.2.007 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere

Es una hiperemesis gravísica clásica.

PREGUNTA 20 **Respuesta: C**

Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad

3.01.1.011 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Antihipertensivos en el Embarazo: En el embarazo, la mayoría de los antihipertensivos están contraindicados. Los cuatro medicamentos que se pueden usar son alfametildopa, nifedipino (de liberación prolongada o XR), hidralazina y labetalol vía oral (más eficaz, pero su disponibilidad es limitada).

PREGUNTA 21 **Respuesta: C**

Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad

3.01.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La HTA crónica se diagnostica antes de la semana 20. B) Incorrecta. La hipertensión gestacional no presenta proteinuria significativa (< 300 mg/24h). C) Correcta. La paciente presenta hipertensión arterial de novo diagnosticada después de la semana 20 (semana 32), asociada a proteinuria significativa (450 mg en 24 horas, umbral ≥ 300 mg), en ausencia de síntomas premonitorios de eclampsia o daño de órgano blanco hematológico, hepático o renal (plaquetas normales, enzimas hepáticas normales, creatinina normal y PA < 160/110). Esto configura la definición exacta de Preeclampsia sin Criterios de Severidad. D) Incorrecta. El síndrome HELLP requiere hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia < 100.000. E) Incorrecta. No tiene síntomas neurológicos.

PREGUNTA 22 **Respuesta: C**

Trastornos Hipertensivos del Embarazo: HTA Crónica, HTA Gestacional y Preeclampsia sin Criterios de Severidad

3.01.1.011 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Es el fármaco de primera línea seguro. B) Incorrecta. Es un antihipertensivo central con amplísimo perfil de seguridad en embarazo. C) Correcta. Los Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA, como Enalapril) y los Antagonistas de los Receptores de Angiotensina II (ARA-II, como Losartán) están absolutamente contraindicados en el embarazo. Durante el 2.° y 3.er trimestre, el bloqueo del sistema renina-angiotensina fetal causa disminución crítica de la perfusión renal del feto, produciendo anuria, oligohidramnios severo (secuencia de Potter), hipoplasia pulmonar letal, hipocalvaria ósea y muerte perinatal. D) Incorrecta. Es un bloqueador de canales de calcio seguro. E) Incorrecta. Vasodilatador seguro en crisis hipertensiva.

PREGUNTA 23 **Respuesta: A**

Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio

3.01.2.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Preeclampsia severa a ≥34 semanas: hospitalización + control de PA (labetalol o hidralazina EV) + sulfato de magnesio para prevenir eclampsia + interrupción del embarazo una vez estabilizada.

PREGUNTA 24 **Respuesta: C**

Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio

3.01.2.004 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene una eclamsia, en contexto de una preclamsia severa. El manejo sigue el siguiente orden: 1. Estabilizar a la paciente y 2. Interrumpir el embarazo. La estabilización también Gene un orden: ABC, luego MgSO4 EV y luego labetalol EV si PA >160/110 (en la práctica se hace todo junto). Aunque en la práctica se hace una cesárea, lo correcto académicamente es que la interrupción del embarazo debe privilegiar la vía vaginal (menos sangrado y estrés quirúrgico), a menos que haya signos de sufrimiento fetal, no se pueda estabilizar a la madre o tenga un cuello cerrado y largo (Bishop < 6-7), ya que demoraría mucho el parto, el que idealmente debe ocurrir antes de que pasen 24 horas desde la eclamsia. La maduración pulmonar puede estar indicada en este caso, por tener menos de 34 semanas, pero no alcanzará a hacer efecto (demora 48 horas).

PREGUNTA 25 **Respuesta: B**

Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio

3.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Aumentar el magnesio provocaría paro respiratorio y cardíaco inminente. B) Correcta. La paciente presenta una Intoxicación Aguda por Sulfato de Magnesio, manifestada por la tríada clásica: abolición del reflejo rotuliano (ocurre con magnesemia > 8-10 mEq/L), bradipnea/depresión respiratoria con FR < 12 rpm (ocurre con niveles > 10-12 mEq/L) y oliguria (< 30 mL/h) que favorece la acumulación del fármaco al excretarse 100% por vía renal. La conducta inmediata de emergencia consiste en suspender de inmediato la infusión de sulfato de magnesio y administrar el antídoto específico: Gluconato de Calcio al 10% (1 ampolla de 10 mL = 1 gramo) administrado por vía endovenosa lenta en 3 a 5 minutos para antagonizar el bloqueo neuromuscular. C) Incorrecta. El diazepam empeoraría la depresión respiratoria. D) Incorrecta. El gluconato de calcio revierte el bloqueo; la intubación solo se requiere si persiste el paro respiratorio. E) Incorrecta. Los diuréticos no revierten la toxicidad aguda.

PREGUNTA 26 **Respuesta: C**

Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio

3.01.2.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La hepatitis no presenta hemólisis microangiopática ni plaquetopenia con hipertensión arterial. B) Incorrecta. La epigastralgia en preeclampsia refleja distensión de la cápsula hepática de Glisson. C) Correcta. El cuadro clínico y analítico cumple estrictamente los criterios diagnósticos del Síndrome HELLP (Tennessee): Hemólisis microangiopática (esquistocitos, LDH > 600 U/L, bilirrubina indirecta elevada), Enzimas hepáticas elevadas (AST/ALT > 70 U/L) y Plaquetopenia (< 100.000/mm³), en una paciente con hipertensión severa y dolor en cuadrante superior derecho. El síndrome HELLP es una emergencia obstétrica que requiere hospitalización inmediata en UCI/ARO, profilaxis con Sulfato de Magnesio, control antihipertensivo y la interrupción expedita del embarazo (independiente de la edad gestacional), que constituye el único tratamiento causal curativo. D) Incorrecta. El contexto hipertensivo del tercer trimestre define HELLP. E) Incorrecta. El hígado graso cursa con hipoglicemia severa, hiperuricemia extrema y coagulopatía precoz.

PREGUNTA 27 **Respuesta: B**

Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio

3.01.2.004 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. El nitroprusiato produce toxicidad fetal por cianuro/tiocianato y se reserva como último recurso ante edema pulmonar masivo refractario. B) Correcta. Para el manejo agudo de la crisis hipertensiva severa en el embarazo (PA ≥ 160/110 mmHg), el fármaco endovenoso de primera línea y de elección absoluta es el Labetalol EV. Se inicia con un bolo de 20 mg EV directo en 2 minutos; si a los 10-20 minutos la PA persiste en rango severo, se administra un segundo bolo de 40 mg, y posteriormente 80 mg cada 10-20 minutos hasta una dosis máxima de 220-300 mg. La meta es reducir la PA a 140-150 / 90-100 mmHg para prevenir la hemorragia cerebral materna sin comprometer la perfusión placentaria. C) Incorrecta. Los IECA están absolutamente contraindicados en el embarazo. D) Incorrecta. La furosemida disminuye el volumen intravascular y contrae la volemia. E) Incorrecta. La vía sublingual de nifedipino está proscrita por riesgo de caída tensional precipitada no controlada, muerte fetal y ACV materno.

PREGUNTA 28 **Respuesta: B**

Emergencias Hipertensivas en el Embarazo: Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP y Sulfato de Magnesio

3.01.2.004 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. No es la causa principal en eclampsia. B) Correcta. En las pacientes con eclampsia y crisis hipertensivas severas del embarazo, la complicación fatal más frecuente que explica más del 60-70% de las muertes maternas es el Accidente Cerebrovascular Hemorrágico (Hemorragia Intracerebral masiva secundaria al fallo de la autorregulación vascular cerebral ante presiones arteriales extremas). Por esta razón, el control enérgico de la crisis hipertensiva con Labetalol o Nifedipino y la profilaxis con Sulfato de Magnesio son de máxima urgencia vital. C) Incorrecta. La injuria renal causa morbilidad pero rara vez mortalidad inmediata. D) Incorrecta. Extremadamente raro. E) Incorrecta. Es una catástrofe del parto pero no secundaria a eclampsia.

PREGUNTA 29 **Respuesta: E**

Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia

3.01.1.004 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Tiene una glicemia mayor a 105 (ahora el corte es 100). Si fuera menor a 100 se observa, si es mayor, se repite. El TTGO se pide a las 28 semanas y luego a las 32 si hay macrosomía, PHA o antecedentes de DMG en otro embarazo.

PREGUNTA 30 **Respuesta: C**

Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia

3.01.1.004 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. El valor a las 2 horas está alterado (≥ 140 mg/dL). B) Incorrecta. En el embarazo no existe la categoría de 'intolerancia' separada; ≥ 140 mg/dL a las 2h es formalmente Diabetes Gestacional. C) Correcta. La norma chilena del MINSAL establece que un valor de glicemia a las 2 horas post-carga de 75 g de glucosa ≥ 140 mg/dL en el segundo trimestre es diagnóstico categórico de Diabetes Gestacional. El pilar de tratamiento inicial es la terapia médico-nutricional con dieta normocalórica fraccionada y automonitoreo de glicemias capilares pre y postprandiales durante 1 a 2 semanas antes de evaluar la necesidad de insulina. D) Incorrecta. La diabetes pregestacional se pesquisa en el primer trimestre con glicemias ≥ 126 mg/dL. E) Incorrecta. La metformina no es el fármaco de primera línea de elección según el MINSAL; si la dieta fracasa se usa insulina.

PREGUNTA 31 **Respuesta: B**

Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia

3.01.1.004 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. Dejar a la paciente con hiperglicemias postprandiales no controladas aumentará el riesgo de macrosomía y muerte fetal. B) Correcta. El criterio estándar para iniciar farmacoterapia en Diabetes Gestacional es la presencia de más del 20% de los controles glucémicos por encima de las metas terapéuticas (en este caso 8 de 28 = 28.5% alterados tras 2 semanas de dieta). El tratamiento farmacológico de elección indiscutido en Chile es la Insulina humana (NPH y/o rápida), que logra un control metabólico óptimo sin atravesar la barrera placentaria. C) Incorrecta. El ayuno genera cetonemia y desnutrición fetal. D) Incorrecta. La glibenclamida atraviesa la placenta y causa hiperinsulinismo e hipoglicemia neonatal severa prolongada. E) Incorrecta. La interrupción precoz sin intentar optimizar el control no está justificada.

PREGUNTA 32 **Respuesta: B**

Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia

3.01.1.004 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. Desarrollan hipoglicemia por exceso de insulina fetal, no hiperglicemia. B) Correcta. La glucosa materna atraviesa libremente la placenta por difusión facilitada, mientras que la insulina materna no la cruza. La hiperglicemia fetal crónica estimula la hipertrofia e hiperplasia de los islotes de células beta pancreáticas fetales con secreción masiva de insulina fetal. Al nacer y clampear el cordón umbilical, el suministro continuo de glucosa materna cesa de forma inmediata, pero los niveles de insulina del neonato permanecen marcadamente elevados, provocando una rápida captación de glucosa celular y una caída crítica de la glicemia (< 40-45 mg/dL) en las primeras 1 a 4 horas de vida. C) Incorrecta. No es autoinmune. D) Incorrecta. Es una malformación estructural asociada a oligoamnios extremo. E) Incorrecta. Suelen desarrollar hipocalcemia e hipomagnesemia.

PREGUNTA 33 **Respuesta: B**

Diabetes Gestacional y Pregestacional: Tamizaje PTGO 75g (24-28 sem), Metas Glucémicas e Insulinoterapia

3.01.1.004 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. El umbral chileno en ayunas en el primer trimestre es 100 mg/dL. B) Correcta. La guía perinatal del MINSAL establece que una glicemia en ayunas en el primer trimestre entre 100 y 125 mg/dL comprobada en dos oportunidades en días distintos es diagnóstica de Diabetes Gestacional de inicio precoz. Requiere ingreso inmediato a programa de diabetes y embarazo para terapia nutricional y automonitoreo sin esperar la semana 24. C) Incorrecta. La diabetes pregestacional manifiesta requiere glicemia en ayunas ≥ 126 mg/dL en dos ocasiones. D) Incorrecta. Es formalmente una diabetes gestacional. E) Incorrecta. Dos tomas alteradas confirman el diagnóstico.

PREGUNTA 34 **Respuesta: D**

Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico

3.01.1.003 | Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

El diagnóstico de la colestasia intrahepática es clínico y no requiere de exámenes. Sin embargo, las fosfatasas alcalinas se elevan con mucha frecuencia, mientras que la bilirrubina puede ser normal.

PREGUNTA 35 **Respuesta: B**

Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico

3.01.1.003 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. La erupción polimorfa (PUPPP) presenta pápulas y placas eritematosas en estrías abdominales con respeto periumbilical. B) Correcta. El prurito palmo-plantar nocturno sin lesiones primarias, transaminasas elevadas y ácidos biliares séricos ≥ 40 umol/L (54 umol/L) confirma el diagnóstico de Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE) Severa. El tratamiento farmacológico de elección avalado internacionalmente y por el MINSAL es el Ácido Ursodesoxicólico (UDCA) a dosis de 10 a 15 mg/kg/día por vía oral, el cual depura los ácidos biliares tóxicos y alivia el prurito materno. Además, por ser severa (≥ 40 umol/L), se debe programar la interrupción a las 36 semanas. C) Incorrecta. El hígado graso cursa con insuficiencia hepática, hipoglicemia y coagulopatía. D) Incorrecta. La escabiosis presenta surcos acarianos interdigitales y prurito familiar. E) Incorrecta. No tiene hipertensión ni proteinuria.

PREGUNTA 36 **Respuesta: B**

Colestasia Intrahepática del Embarazo (CIE): Prurito Palmoplantar, Ácidos Biliares y Ácido Ursodesoxicólico

3.01.1.003 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. Los ácidos biliares no alteran la física del ultrasonido. B) Correcta. En la Colestasia Intrahepática del Embarazo, a diferencia del RCF o la preeclampsia donde existe una insuficiencia placentaria crónica progresiva detectable con Doppler, el óbito fetal ocurre típicamente de forma aguda, súbita e impredecible en fetos con crecimiento y líquido amniótico normales. El mecanismo patogénico es la toxicidad directa de los ácidos biliares sobre los miocardiocitos fetales (generando arritmias cardíacas fatales) y vasoespasmo agudo de las venas de la placa coriónica. Por ello, un RBNE normal no predice la sobrevida a corto plazo y la única estrategia eficaz para evitar el óbito es la interrupción programada del embarazo entre las 36 y 38 semanas según niveles de ácidos biliares. C) Incorrecta. La FCF basal suele ser normal. D) Incorrecta. El feto tiene riesgo severo de muerte intrauterina. E) Incorrecta. El UDCA no altera el RBNE.

PREGUNTA 37 **Respuesta: E** **Presentaciones fetales anómalas** 3.01.2.013 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Tiene una presentación de cara, que se maneja con cesárea, salvo que sea mento- anterior, que no es el caso.

PREGUNTA 38 **Respuesta: C**

Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030

3.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Tiene un aborto séptico e incompleto, con restos ovulares retenidos. Se maneja con antibióticos endovenosos de amplio espectro y evacuación uterina mediante curetaje o AMEU.

PREGUNTA 39 **Respuesta: B**

Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030

3.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. En el aborto incompleto el OCI está permeable y se observan restos ovulares desorganizados, no un embrión vital con LCF presentes. B) Correcta. El cuadro clásico de metrorragia de la primera mitad del embarazo con OCI cerrado y visualización ecográfica de un embrión con actividad cardíaca presente y normal (LCF +) corresponde a una Amenaza de Aborto. La conducta recomendada por MINSAL consiste en descartar patología infecciosa cervical o urinaria concomitante, indicar reposo físico y reposo sexual (abstinencia), y seguimiento ambulatorio. No se aconseja el uso rutinario de progesterona si no hay antecedentes de abortos recurrentes. C) Incorrecta. El embrión está vivo con LCF presentes; el misoprostol provocaría un aborto. D) Incorrecta. El saco está normoinserto intrauterino, descartando embarazo ectópico. E) Incorrecta. El aborto inevitable cursa con cuello dilatado y membranas rotas, lo cual no ocurre aquí.

PREGUNTA 40 **Respuesta: B**

Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030

3.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Realizar un legrado instrumental a ciegas sobre un útero séptico friable sin impregnación antibiótica previa desencadena una bacteriemia masiva que conduce a shock séptico refractario y aumenta enormemente el riesgo de perforación uterina. B) Correcta. La combinación de fiebre alta, dolor hipogástrico, loquios o secreción purulenta fétida y útero doloroso subinvolucionado tras un aborto configura un Aborto Séptico. Es una emergencia infectológica mayor. La conducta médica oficial consiste en hospitalización inmediata en UTI/UCI, reanimación con fluidos, toma de cultivos, inicio precoz de antibioticoterapia parenteral de amplio espectro con triple asociación (ej. Ceftriaxona/Gentamicina + Ampicilina + Metronidazol o Clindamicina) para esterilizar el torrente sanguíneo, y posteriormente (a las 2 a 4 horas de iniciada la cobertura antibiótica) proceder a la evacuación uterina instrumental mediante AMEU o curetaje suave. C) Incorrecta. La vía oral y el manejo ambulatorio están estrictamente proscritos en el aborto séptico. D) Incorrecta. El misoprostol solo no trata la infección bacteriana invasiva ni garantiza la evacuación rápida en sepsis. E) Incorrecta. La histerectomía se reserva para casos de falla multiorgánica refractaria, gangrena miometrial por Clostridium o perforación uterina comprobada.

PREGUNTA 41 **Respuesta: C**

Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030

3.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. En la amenaza de aborto el OCI está estrictamente cerrado. B) Incorrecta. En el aborto retenido el OCI está cerrado y el tejido no está siendo expulsado activamente. C) Correcta. La conjunción de metrorragia activa, cuello con OCI permeable/abierto donde se palpan tejidos ovulares o restos, y confirmación ecográfica de restos intrauterinos desorganizados define el Aborto Incompleto. El tratamiento consiste en la evacuación de la cavidad mediante AMEU o Misoprostol. D) Incorrecta. En el aborto completo el cuello ya se ha cerrado y la ecografía muestra un endometrio delgado y lineal sin restos. E) Incorrecta. Aunque la mola muestra restos vesiculares, la presencia de OCI abierto con expulsión de restos fetoplacentarios típicos corresponde a la definición clínica de aborto incompleto.

PREGUNTA 42 **Respuesta: B**

Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030

3.01.1.001 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La ley chilena no exige que haya denuncia policial ni fallo condenatorio; basta la declaración de la mujer y la evaluación del equipo de salud multidisciplinario. B) Correcta. La Ley 21.030 establece para la tercera causal (violación) un límite estricto de edad gestacional de hasta 12 semanas de gestación en mujeres mayores de 14 años, y se extiende hasta las 14 semanas de gestación cuando la víctima es una menor de 14 años. C) Incorrecta. El profesional que manifiesta objeción de conciencia tiene el deber legal estricto de derivar de inmediato a la paciente a un equipo o institución que realice la prestación. D) Incorrecta. La única causal sin límite temporal de edad gestacional es la Causal 1 (riesgo vital materno) y la Causal 2 (inviabilidad fetal letal). E) Incorrecta. No requiere aprobación de comité ético, sino verificación médica y del equipo psicosocial.

PREGUNTA 43 **Respuesta: A**

Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030

3.01.2.001 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar

La opción A es la respuesta correcta. En el enfrentamiento de "Aborto provocado" como urgencia clínica (3.01.2.001), las exigencias del Perfil V3 para el médico general establecen el deber de Diagnóstico Específico, Tratamiento Inicial y Seguimiento Derivar. La prioridad crítica es la reanimación fisiológica inmediata y soporte vital antes de cualquier estudio confirmatorio o diferido. Las opciones B, C, D y E representan conductas que retrasan el tratamiento de rescate o comprometen la seguridad vital del paciente.

PREGUNTA 44 **Respuesta: A**

Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030

3.01.2.010 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Tiene un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI), que se debe interrumpir de inmediato por la vía más expedita, la que, por no tener dilatación cervical, es la cesárea de urgencia. La única excepción, que se puede hospitalizar y observar con mucho cuidado, es que sea menor a 34 semanas, con sangrado escaso, madre bien, feto bien y sin dolor ni contracciones (en otras palabras, < 34 semanas con un poquito y todo tranquilizador).

PREGUNTA 45 **Respuesta: A**

Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico

3.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: No requiere GES

Anemia ferropénica en embarazo (Hb <11 g/dL + microcitosis + ferritina baja): tratamiento de primera línea = hierro oral elemental 200 mg/día. Hierro EV se reserva para intolerancia oral, malabsorción o anemia severa. Transfusión solo en anemia grave sintomática.

PREGUNTA 46 **Respuesta: B**

Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico

3.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La laparotomía abierta y la histerectomía son procedimientos mutilantes completamente desproporcionados y contraindicados para una paciente joven y estable con un ectópico no roto. B) Correcta. La paciente presenta un embarazo ectópico tubárico no roto confirmado por β-hCG > 2.000 UI/L con útero vacío. Cumple con todos los criterios de elegibilidad para el tratamiento médico con Metotrexato a dosis única: hemodinámicamente estable, β-hCG sérica menor a 5.000 UI/L (3.200 UI/L), masa anexial menor de 3.5 cm (2.6 cm), ausencia de latidos cardíacos fetales, sin hemoperitoneo y con función hepática/renal y hemograma normales. Este abordaje médico preserva la indemnidad tubárica con una tasa de resolución cercana al 90%. C) Incorrecta. El manejo expectante solo se permite con β-hCG muy baja (< 1.000 UI/L) y en franco descenso espontáneo confirmado en 48 horas. D) Incorrecta. El embarazo no está en la cavidad uterina; el legrado no resolverá el cuadro y expondrá a la trompa a rotura por retraso diagnóstico. E) Incorrecta. La progesterona no tiene indicación y favorecería el crecimiento del trofoblasto ectópico.

PREGUNTA 47 **Respuesta: B**

Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico

3.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El metotrexato está absolutamente contraindicado ante sospecha de rotura e inestabilidad hemodinámica; su efecto tarda días en manifestarse y la paciente fallecería en minutos. B) Correcta. La combinación de dolor abdominal hiperagudo, síncope, hipotensión severa (75/40), taquicardia extrema (135 lpm), palidez y vientre peritoneal con test de gestación positivo constituye un cuadro clásico de Embarazo Ectópico Roto en Shock Hipovolémico (Hemoperitoneo Masivo). Constituye una emergencia quirúrgica de riesgo vital absoluto. La conducta consiste en soporte hemodinámico inmediato con accesos venosos gruesos, fluidoterapia con cristaloides tibios, hemoderivados (glóbulos rojos) y traslado inmediato a pabellón para laparotomía de urgencia para cohibir el sangrado mediante salpingectomía. C) Incorrecta. Una paciente inestable nunca debe llevarse a un tomógrafo por riesgo de PCR fuera de pabellón. D) Incorrecta. Retrasar la cirugía para esperar una prueba de laboratorio es una negligencia médica letal. E) Incorrecta. El legrado no detiene la hemorragia tubárica intraperitoneal.

PREGUNTA 48 **Respuesta: B**

Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico

3.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. El aumento transitorio de la β-hCG entre el Día 1 y el Día 4 es fisiológico debido a la lisis trofoblástica inicial inducida por el fármaco, y no se considera fracaso. B) Correcta. El cálculo matemático muestra: del Día 4 (2.650 UI/L) al Día 7 (2.100 UI/L) hubo una reducción de 550 UI/L. El porcentaje de reducción es: (550 / 2.650) * 100 = 20.75%. Como 20.75% es superior al umbral exigido del 15% de reducción entre el día 4 y el día 7, el tratamiento se clasifica formalmente como exitoso. La conducta médica es continuar la monitorización ambulatoria semanal de la β-hCG sérica hasta alcanzar concentraciones indetectables (< 5 UI/L). C) Incorrecta. El descenso fue del 20.75%, que supera el 15%. D) Incorrecta. No está de alta; el seguimiento semanal es obligatorio hasta la negativización total. E) Incorrecta. La leucovorina no está indicada en el esquema de dosis única.

PREGUNTA 49 **Respuesta: C**

Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico

3.01.1.002 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La porción ampular se rompe entre las 6 y 8 semanas. B) Incorrecta. La porción ístmica es la más estrecha y se rompe muy precozmente (antes de las 6 semanas). C) Correcta. El embarazo ectópico intersticial (o cornual) se implanta en el segmento intramural de la trompa que atraviesa el miometrio uterino. Debido a la mayor distensibilidad de las fibras miometriales que rodean este segmento, el saco gestacional puede crecer durante más tiempo, rompiéndose típicamente en forma tardía entre las 12 y 16 semanas de gestación. Dado que en esa zona se localiza la anastomosis entre la arteria uterina y la arteria ovárica, su rotura causa una hemorragia cataclísmica y exanguinante masiva, con alta mortalidad materna. D) Incorrecta. La porción fímbrica suele culminar en aborto tubárico hacia la cavidad abdominal. E) Incorrecta. El ectópico cervical produce hemorragia vaginal indolora masiva, no hemoperitoneo.

PREGUNTA 50 **Respuesta: C**

Embarazo Ectópico: Localizaciones, Diagnóstico con β-hCG Cuantitativa, Manejo Médico (Metotrexato) vs Quirúrgico

3.01.2.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Embarazo ectópico roto

PREGUNTA 51 **Respuesta: B**

Enfermedad Trofoblástica Gestacional: Mola Completa vs Parcial, Criterios de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) y Seguimiento

3.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La histerectomía total se reserva para pacientes añosas con paridad satisfecha que no desean fertilidad, y la salpingooforectomía es innecesaria porque los ovarios regresan espontáneamente al normalizarse la hCG. B) Correcta. El tratamiento de elección para la mola hidatiforme es la evacuación inmediata de la cavidad uterina mediante aspiración al vacío (aspiración mecánica o AMEU) bajo goteo de oxitocina, enviando todo el tejido a confirmación anatomopatológica. Se prefiere la aspiración sobre el legrado instrumental cortante por el elevado riesgo de hemorragia profusa y perforación del miometrio reblandecido. C) Incorrecta. El uso de misoprostol o agentes inductores de contracciones aislados aumenta drásticamente el riesgo de embolización pulmonar de tejido trofoblástico. D) Incorrecta. La quimioterapia no es el tratamiento inicial de la mola hidatiforme; solo se reserva para las pacientes que desarrollan una Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) durante el seguimiento. E) Incorrecta. Los quistes tecaluteínicos no deben puncionarse ni extirparse; son una respuesta fisiológica benigna que involuciona espontáneamente al evacuar la mola.

PREGUNTA 52 **Respuesta: B**

Enfermedad Trofoblástica Gestacional: Mola Completa vs Parcial, Criterios de Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) y Seguimiento

3.01.1.003 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Los valores de β-hCG se estancaron y comenzaron a ascender entre la semana 2 y 4, lo que descarta una evolución normal. B) Correcta. El criterio diagnóstico de la FIGO para Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG) se cumple cuando la β-hCG se mantiene en meseta durante tres semanas consecutivas o cuando se constata un ascenso de los valores en dos o más mediciones sucesivas durante el seguimiento postmolar. En esta paciente, los niveles pasaron de 3.500 a 3.600 y luego a 3.800 UI/L, lo cual confirma NTG (mola invasora o coriocarcinoma). La conducta médica obligatoria es etapificar a la paciente (mediante examen clínico, TAC de tórax-abdomen-pelvis) para calcular el score pronóstico FIGO e iniciar tratamiento con quimioterapia (generalmente Metotrexato si es bajo riesgo). C) Incorrecta. A las 4 semanas de una mola no se trata de un nuevo embarazo normal, sino de proliferación trofoblástica activa invasora. D) Incorrecta. La infección no produce elevación de la β-hCG. E) Incorrecta. Un segundo legrado no cura la NTG y eleva el riesgo de perforación y hemorragia sin beneficio demostrado.

PREGUNTA 53 **Respuesta: B**

Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda

3.01.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. En la embarazada la bacteriuria asintomática siempre debe tratarse para evitar la progresión a pielonefritis. B) Correcta. El hallazgo de ≥ 100.000 UFC/mL en una gestante asintomática define Bacteriuria Asintomática. La norma oficial del MINSAL y la evidencia médica indican tratamiento antibiótico obligatorio con Cefadroxilo oral 500 mg cada 12 horas por 7 días (o Nitrofurantoína por 7 días), seguido de un urocultivo de control a los 7 a 14 días post-tratamiento para certificar la curación microbiológica. El tratamiento reduce la incidencia de pielonefritis de un 30-40% a menos del 3-5%. C) Incorrecta. La vía endovenosa se reserva para pielonefritis sintomática. D) Incorrecta. El arándano no sustituye la terapia antimicrobiana curativa. E) Incorrecta. Postergar el tratamiento expone a la paciente a pielonefritis en el segundo trimestre.

PREGUNTA 54 **Respuesta: B**

Infección del Tracto Urinario en el Embarazo: Bacteriuria Asintomática, Cistitis y Pielonefritis Aguda

3.01.1.019 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La pielonefritis aguda en el embarazo NUNCA se trata en forma ambulatoria por el alto riesgo de bacteriemia, shock séptico, SDRA y parto prematuro. B) Correcta. La combinación de fiebre alta, calofríos y puñopercusión lumbar positiva en el embarazo es diagnóstica de Pielonefritis Aguda. Toda pielonefritis en el embarazo requiere HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA para hidratación parenteral vigorosa, monitorización de la dinámica uterina y bienestar fetal, y antibioticoterapia endovenosa empírica inmediata con Cefalosporinas de 1.ª o 3.ª generación (Cefazolina 1 g c/8h EV o Ceftriaxona 1 a 2 g c/24h EV), manteniéndola hasta 48 horas afebril y completando 14 días por vía oral. C) Incorrecta. Las fluoroquinolonas están contraindicadas en el embarazo por toxicidad sobre el cartílago de crecimiento fetal. D) Incorrecta. El parto no está indicado; la infección se trata médicamente y las contracciones suelen ceder al enfriar el cuadro infeccioso. E) Incorrecta. Negligente ante una infección sistémica.

BLOQUE 4 METRORRAGIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 55 **Respuesta: B**

Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa

3.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La ecografía transvaginal es el método diagnóstico de elección y es completamente segura, ya que el transductor se ubica en el fondo de saco vaginal anterior a más de 2 cm del cuello. B) Correcta. En toda paciente que consulta por metrorragia del tercer trimestre con sospecha de placenta previa (sangrado indoloro, útero blando, feto reactivo), el TACTO VAGINAL DIGITAL está ESTRICTAMENTE CONTRAINDICADO. La introducción del dedo a través del canal cervical puede desgarrar la masa placentaria o vasos nutricios de gran calibre, provocando una hemorragia masiva exanguinante inmediata que amenaza la vida de la madre y del feto. C) Incorrecta. Instalar vías venosas gruesas es parte esencial de la estabilización. D) Incorrecta. La especuloscopía suave permite certificar si la sangre proviene de la cavidad uterina o de una lesión cervical/vaginal local. E) Incorrecta. El estudio hematológico y de coagulación es imperativo.

PREGUNTA 56 **Respuesta: B**

Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa

3.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La placenta previa no produce dolor intenso ni hipertonía uterina leñosa. B) Correcta. La combinación de metrorragia con sangre oscura, dolor abdominal intenso y continuo, hipertonía uterina leñosa ('útero en tabla') y sufrimiento fetal agudo (bradicardia fetal y DIP II) en una paciente hipertensa es la presentación clásica del Desprendimiento Prematuro de Placenta Normoinserta (DPPNI o Abruptio Placentae). Representa una emergencia obstétrica crítica con altísimo riesgo de muerte fetal intrauterina y coagulopatía de consumo materna (CID). Con feto vivo y viable a las 35 semanas, la conducta mandatoria es la interrupción inmediata mediante cesárea de urgencia junto a reanimación materna. C) Incorrecta. En la vasa previa el sangrado es indoloro tras romper membranas y el útero no está hipertónico. D) Incorrecta. Los tocolíticos están contraindicados ante sospecha de desprendimiento placentario. E) Incorrecta. El cuadro es netamente obstétrico de riesgo vital.

PREGUNTA 57 **Respuesta: C**

Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa

3.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La placenta previa no produce cese súbito de contracciones ni ascenso de la presentación. B) Incorrecta. La embolia de líquido amniótico debuta con colapso cardiopulmonar fulminante, hipoxemia y convulsiones sin ascenso fetal palpable. C) Correcta. El dolor desgarrador súbito seguido por el cese instantáneo de las contracciones uterinas, shock hipovolémico materno, ascenso y desaparición de la presentación fetal en la pelvis, y palpación muy superficial de las partes fetales en el abdomen en una paciente con cicatriz de cesárea anterior bajo oxitócicos es patognomónico de Rotura Uterina Completa. El feto ha sido expulsado hacia la cavidad peritoneal. Requiere laparotomía exploradora inmediata de emergencia para extracción fetal y hemostasia quirúrgica materna. D) Incorrecta. En el DPPNI el útero se mantiene hipertónico y duro, no cesan las contracciones ni asciende la presentación fetal a la cavidad abdominal. E) Incorrecta. La inversión uterina ocurre en el alumbramiento o postparto con masa que protruye por vagina.

PREGUNTA 58 **Respuesta: A**

Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa

3.01.1.004 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Correcta. La secuencia clínica patognomónica de metrorragia que aparece inmediatamente tras la rotura de membranas ovulares (amniotomía o amniorrexis) asociada a sufrimiento fetal agudo severo e instantáneo (bradicardia severa o patrón sinusoidal), en una madre totalmente asintomática y con útero relajado, es la manifestación clásica de la Rotura de Vasa Previa. Los vasos umbilicales aberrantes velamentosos que atraviesan el orificio cervical interno se desgarran al romperse las membranas; la sangre es de origen fetal, por lo que el feto sufre una exanguinación fulminante en pocos minutos. Exige cesárea emergente inmediata. B) Incorrecta. La placenta previa sangra antes de romper membranas de forma espontánea y no se asocia al acto de la amniotomía de vasos aberrantes. C) Incorrecta. El DPPNI se asocia a dolor intenso e hipertonía uterina, ausentes en este caso. D) Incorrecta. La laceración de cuello no causa bradicardia fetal extrema inmediata. E) Incorrecta. La corioamnionitis cursa con fiebre materna y taquicardia fetal.

PREGUNTA 59 **Respuesta: E**

Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa

3.01.2.011 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Tiene una placenta previa sintomática, por lo que debe interrumpirse por cesárea. Si bien está en buenas condiciones, ya tiene más de 34 semanas, por lo que se interrumpe sin mayor riesgo de complicaciones por prematurez.

PREGUNTA 60 **Respuesta: D**

Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo: Placenta Previa, DPPNI, Rotura Uterina y Rotura de Vasa Previa

3.01.2.015 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Rotura uterina (dolor súbito diferente a contracciones + bradicardia fetal + antecedente de cicatriz uterina): emergencia obstétrica máxima. Cesárea de urgencia INMEDIATA. El fórceps/vacuum están absolutamente contraindicados. Sin tratamiento puede ser fatal para madre y feto.

PREGUNTA 61 **Respuesta: A**

Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis

3.01.1.005 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 98). Evalúa el manejo clínico de Embarazo con edad gestacional dudosa según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 62 **Respuesta: B**

Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis

3.01.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. En < 34 semanas sin infección el manejo es conservador; el tacto vaginal arrastra gérmenes y la inducción prematura expone al feto a morbimortalidad severa. B) Correcta. En una RPM pretérmino entre 24 y 34 semanas sin signos de infección ovular, la conducta estándar recomendada por el MINSAL es el manejo expectante en una Unidad de ARO. Esto incluye la administración de Betametasona (12 mg IM c/24h x 2 dosis) para acelerar la maduración pulmonar fetal y reducir hemorragia intraventricular, y el esquema de antibioticoterapia de latencia (Ampicilina EV + Eritromicina EV por 48 horas, seguido de Amoxicilina + Eritromicina/Azitromicina oral hasta completar 7 días) para prolongar el tiempo de latencia libre de parto y disminuir el riesgo de infección neonatal. C) Incorrecta. La RPM pretérmino exige hospitalización estricta. D) Incorrecta. La cesárea no está indicada de urgencia en ausencia de sufrimiento fetal o corioamnionitis. E) Incorrecta. La tocolisis prolongada no mejora los resultados perinatales y está contraindicada.

PREGUNTA 63 **Respuesta: B**

Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis

3.01.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La tocolisis en corioamnionitis perpetúa un foco infeccioso que puede costar la vida materna y fetal por shock séptico. B) Correcta. La paciente cumple estrictamente todos los criterios de Gibbs para Corioamnionitis Clínica (fiebre materna alta, taquicardia materna y fetal, dolor a la palpación uterina, líquido amniótico purulento/fétido y leucocitosis con desviación izquierda). La corioamnionitis es una EMERGENCIA OBSTÉTRICA que contraindica cualquier conducta expectante o retraso. La conducta obligatoria es la hospitalización en sala de partos/quirófano, inicio inmediato de antibioticoterapia EV de amplio espectro (Ampicilina 2g c/6h EV + Gentamicina 5 mg/kg/día EV) y la INTERRUPCIÓN INMEDIATA del embarazo por la vía más expedita (habitualmente inducción oxitócica si el parto es rápido, o cesárea si hay distocia o sufrimiento fetal severo). C) Incorrecta. Los corticoides están contraindicados ante infección intraamniótica manifiesta. D) Incorrecta. Esperar cultivos ante un diagnóstico clínico evidente de sepsis ovular es una mala praxis letal. E) Incorrecta. La conducta expectante está proscrita ante corioamnionitis.

PREGUNTA 64 **Respuesta: A**

Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis

3.01.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Correcta. En una paciente con Rotura Prematura de Membranas a partir de las 34 semanas de gestación (en este caso 36 semanas), la conducta consensuada oficial por el MINSAL y la FIGO es la INTERRUPCIÓN INMEDIATA DEL EMBARAZO mediante inducción del parto (mediante oxitocina o maduración previa con misoprostol si el Bishop es desfavorable). A esta edad gestacional los riesgos infecciosos materno-fetales superan a los riesgos de la prematuridad tardía. B) Incorrecta. Los corticoides no están indicados en mayores de 34 semanas en el contexto de RPM. C) Incorrecta. Los antibióticos de latencia se usan en < 34 semanas; en ≥ 34 semanas solo se aplica profilaxis contra SGB si el cultivo es positivo o la latencia supera las 12-18 horas. D) Incorrecta. La tocolisis está formalmente contraindicada en ≥ 34 semanas. E) Incorrecta. No se puede esperar semanas con membranas rotas por el altísimo riesgo de corioamnionitis.

PREGUNTA 65 **Respuesta: B**

Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis

3.01.1.005 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La especuloscopía estéril es el estándar diagnóstico de elección. B) Correcta. El tacto vaginal digital está terminantemente contraindicado en la sospecha de RPM sin trabajo de parto evidente, ya que introduce bacterias patógenas desde el vestíbulo y vagina profunda hacia el canal endocervical y la cavidad amniótica, reduciendo significativamente el tiempo de latencia y multiplicando por 3 a 5 veces el riesgo de infección intraamniótica (corioamnionitis) y sepsis neonatal temprana. C) Incorrecta. Es una prueba confirmatoria válida y segura. D) Incorrecta. El test de nitrazina es una prueba útil y segura. E) Incorrecta. El test AmniSure es altamente específico y no invasivo.

PREGUNTA 66 **Respuesta: C**

Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis

3.01.2.012 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Manejo del Trabajo de Parto Prematuro: En amenaza de parto prematuro menor a 34 semanas se usan corticoides y tocolíticos. La indometacina se recomienda en menores de 32 semanas; el nifedipino desde las 32 semanas en adelante. El atosibán es tocolítico de segunda línea.

PREGUNTA 67 **Respuesta: A**

Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis

3.01.2.014 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

RPM a las 35 semanas: manejo conservador con hospitalización, corticoides (betametasona) para maduración pulmonar, antibióticos profilácticos (ampicilina + eritromicina) y monitoreo fetal estrecho.

PREGUNTA 68 **Respuesta: D**

Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección

3.01.1.006 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Embarazo ectópico no complicado: El diagnóstico es un embarazo ectópico no complicado, basado en los niveles de hCG mayores a 3500 y la ausencia de un saco gestacional visible en la ecografía transvaginal. La paciente no tiene contraindicaciones para el metotrexato, ya que el tumor anexial es menor a 4 cm y los niveles de hCG son menores a 5000. El tratamiento de elección en este caso es el metotrexato. Si los niveles de hCG hubieran sido inferiores a 3500, la respuesta habría sido repetir los niveles de hCG en 48 horas. Si el tumor anexial hubiera sido mayor a 4 cm o la hCG mayor a 5000, la respuesta habría sido una salpingectomía por laparoscopía. Si la paciente hubiera estado en shock, la respuesta correcta habría sido la salpingectomía inmediata, ya sea por vía abierta o laparoscópica.

PREGUNTA 69 **Respuesta: B**

Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección

3.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La paciente tiene un cuadro activo de APP con cérvix marcadamente acortado y dilatado; el manejo ambulatorio es una grave negligencia. B) Correcta. La presencia de dinámica uterina regular con cérvix corto de 16 mm (< 25 mm) a las 30 semanas de gestación confirma una Amenaza de Parto Prematuro. El manejo integral hospitalizado de primera línea incluye: 1) Tocolisis con Nifedipino oral durante 48 horas para frenar las contracciones; 2) Betametasona 12 mg IM c/24h x 2 dosis para inducir maduración pulmonar y reducir membrana hialina y hemorragia intraventricular; y 3) Sulfato de Magnesio EV para neuroprotección fetal (reducir parálisis cerebral) al tratarse de una gestación menor de 32 semanas. C) Incorrecta. La cesárea inmediata no está indicada en ausencia de sufrimiento fetal agudo o complicación catastrófica; debe intentarse la tocolisis para permitir la acción del corticoide. D) Incorrecta. La indometacina no se utiliza de mantención prolongada ni ambulatoria por sus graves efectos adversos sobre el feto (cierre del ductus y oligohidramnios). E) Incorrecta. El cerclaje de emergencia está contraindicado en presencia de contracciones uterinas activas francas.

PREGUNTA 70 **Respuesta: C**

Síndrome de Parto Prematuro: Amenaza de Parto Prematuro (APP), Tocolíticos, Maduración Pulmonar y Neuroprotección

3.01.1.006 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Es la indicación típica de tocolisis para permitir la maduración pulmonar. B) Incorrecta. Situación clásica con indicación formal de freno uterino y corticoides. C) Correcta. La Corioamnionitis Clínica es una contraindicación formal y absoluta para cualquier terapia tocolítica. Intentar detener el parto en presencia de una infección ovular invasiva pone en riesgo inminente la vida de la madre (sepsis, shock séptico) y del feto (muerte intrauterina, asfixia, secuelas neurológicas severas). La conducta mandatoria es la interrupción inmediata del embarazo bajo cobertura antibiótica endovenosa de amplio espectro. D) Incorrecta. El embarazo gemelar con APP puede recibir tocolisis para completar corticoides. E) Incorrecta. La ITU puede desencadenar contracciones; mientras se trata el antibiótico, la tocolisis está indicada por 48 horas si hay APP.

PREGUNTA 71 **Respuesta: A**

Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento

3.01.1.007 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Embarazo gemelar bicorial biamniótico: En un embarazo gemelar bicorial biamniótico sin complicaciones, la ecografía muestra fetos con pesos similares y sin restricción del crecimiento intrauterino (por encima del percentil 10). Se suele interrumpir a las 38 semanas. La vía del parto depende de la presentación del primer gemelo y la amniocidad. Si el primer gemelo está en posición cefálica y es biamniótico, se puede realizar un parto vaginal (tanto en monocorial como en bicorial). En cambio, si el primer gemelo no está en posición cefálica o si es monoamniótico, se interrumpe por cesárea. Los monocoriales biamnióticos, se interrumpen a las 36 semanas. Los monoamnióticos, a las 32 a 34 semanas.

PREGUNTA 72 **Respuesta: B**

Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento

3.01.2.021 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

Tiene buena dinámica (3-5 contracciones cada 10 minutos). Está en presentación cefálica de vérGce (punto de referencia es el occipucio), así que no hay distocia de presentación. No Gene criterios de macrosomía fetal (mayor a 4.500 gramos). Tiene posición occipital posterior persistente, lo que es compaGble con una distocia de posición. La posición es la rotación del feto en relación a la pelvis (se describe con el punto de referencia, en relación a una parte de la pelvis). La mayoría de los partos se dan en posición anterior: “occipito púbica” u “occipito ilíaca anterior”, en cambio, las posiciones transversas y posteriores suelen demorar más y, si persisten, se consideran una distocia de posición. No se debe confundir la posición transversa (ej. occipito ilíaca transversa), que puede demorar, pero Gene opción de parto vaginal, con la con presentación transversa (ej. acromio púbica), que obliga a la cesárea desde el inicio.

BLOQUE 5 PARTO PREMATURO, MECANISMO DEL PARTO, PUERPERIO & URGENCIAS OBSTÉTRICAS · SOLUCIONARIO OFICIAL

PREGUNTA 73 **Respuesta: C**

Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

3.01.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es un embarazo molar, confirmado con la ecografía. La HCG muy elevada también la sugiere, al igual que el útero de tamaño mucho mayor al esperado para su edad gestacional (suprapúbico equivale a 12 semanas).

PREGUNTA 74 **Respuesta: B**

Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

3.01.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La maniobra de Kristeller está absolutamente contraindicada en la distocia de hombros por riesgo de rotura uterina y fracturas fetales, al igual que la tracción brusca que rompe el plexo braquial. B) Correcta. Ante una Distocia de Hombros confirmada por el 'signo de la tortuga', el abordaje sistemático de primera línea universalmente validado (protocolo HELPERR / MINSAL) consiste en: 1) Maniobra de McRoberts (hiperflexión extrema de los muslos de la madre contra el abdomen, lo que reduce el ángulo de inclinación de la pelvis y amplía el diámetro funcional sagital), asociada a 2) Presión Suprapúbica (Maniobra de Mazzanti), ejerciendo presión hacia abajo y hacia el lado con la eminencia tenar para rotar y desimpactar el hombro anterior. Esta combinación resuelve con éxito entre el 70% y 85% de los casos sin secuelas. C) Incorrecta. La maniobra de Zavanelli es un recurso heroico desesperado reservado para el fracaso de todas las maniobras internas. D) Incorrecta. La fractura de clavícula no es una maniobra de primera línea. E) Incorrecta. La sinfisiotomía es una técnica mutilante de último recurso en países sin quirófano disponible.

PREGUNTA 75 **Respuesta: B**

Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

3.01.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Las desaceleraciones que coinciden en espejo no indican acidosis ni desprendimiento. B) Correcta. Las desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal que se inician junto con la contracción uterina, alcanzan su nadir en el acmé de la misma ('imagen en espejo' simétrica) y se normalizan al terminar la contracción corresponden a Desaceleraciones Precoces o Tempranas (DIP I). Están causadas por la compresión mecánica transitoria de la cabeza fetal contra el canal del parto, lo que genera un aumento de la presión intracraneal fetal y estimulación vagal parasimpática con caída de la frecuencia. Tienen carácter totalmente fisiológico y benigno, no se asocian a hipoxia ni acidemia, y permiten continuar la evolución normal del parto vaginal. C) Incorrecta. La insuficiencia placentaria e hipoxia se manifiesta como DIP II (tardías). D) Incorrecta. La compresión de cordón produce DIP III (variables en V). E) Incorrecta. La anemia fetal produce trazado sinusoidal oscilatorio.

PREGUNTA 76 **Respuesta: C**

Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

3.01.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La observación expectante ante desaceleraciones tardías con variabilidad ausente causará la muerte fetal o encefalopatía hipóxico-isquémica. B) Incorrecta. Aumentar la oxitocina aumentará las contracciones y asfixiará al feto. C) Correcta. El trazado descrito presenta Desaceleraciones Tardías recurrentes (DIP II) asociadas a pérdida total de la variabilidad fetal, configurando un Patrón de Monitoreo Categoría III (Anormal). Este patrón traduce una hipoxia fetal severa con deuda tisular de oxígeno y acidosis metabólica miocárdica progresiva por insuficiencia útero-placentaria. La conducta obstétrica mandatoria es instaurar de inmediato maniobras de reanimación intrauterina (suspender oxitocina, oxígeno materno, decúbito lateral izquierdo, bolo de cristaloides) y proceder a la resolución inmediata del embarazo mediante cesárea de emergencia. D) Incorrecta. Inadecuado ante un compromiso hipóxico agudo. E) Incorrecta. La peridural puede generar hipotensión materna que agrava la hipoxia fetal.

PREGUNTA 77 **Respuesta: B**

Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

3.01.1.008 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La parálisis facial se asocia clásicamente a la compresión de la rama mandibular por las cucharas del fórceps. B) Correcta. La Parálisis de Erb-Duchenne es la lesión neurológica obstétrica clásica más común de la distocia de hombros. Ocurre por la distensión excesiva o rotura traumática de las raíces superiores del plexo braquial (C5 y C6) provocada por la tracción axial y balanceo lateral vigoroso ejercido sobre la cabeza fetal cuando el hombro está anclado en la pelvis. El recién nacido adopta la típica postura 'en propina de mozo' (brazo en aducción y rotación interna con antebrazo extendido y pronado). C) Incorrecta. La de Klumpke (C8-T1) compromete la mano y es mucho más rara, típica de tracción excesiva en podálica con brazos en alto. D) Incorrecta. El nervio ciático poplíteo no se afecta en la distocia de hombros. E) Incorrecta. Menos frecuente que la parálisis braquial superior.

PREGUNTA 78 **Respuesta: B**

Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

3.01.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Lo más importante es la HCG seriada, para detectar precozmente la aparición de una neoplasia trofoblástica gestacional. Sin embargo, también deberá quedar con ACO, para evitar un embarazo que eleva la HCG y alterará el seguimiento.

PREGUNTA 79 **Respuesta: A**

Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

3.01.1.008 Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar

Ante un embarazo molar se debe seguir con HCG, después de sacarla. Si se eleva o mantiene sin bajar, se diagnostica neoplasia trofoblástica gestacional y se procede a la histerectomía más quimioterapia con metotrexato. Una HCG de 750 postlegrado, es bastante baja.

PREGUNTA 80 **Respuesta: A**

Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado

3.01.1.009 | Dx: Sospecha · Tx: Inicial · Seg: Derivar | GES

Pregunta oficial de examen EUNACOM (EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 97). Evalúa el manejo clínico de Macrosomía fetal según directrices MINSAL vigentes.

PREGUNTA 81 **Respuesta: B**

Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado

3.01.1.009 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. El misoprostol es seguro en pacientes hipertensas y es el fármaco de elección alternativa. B) Correcta. La Metilergonovina (Ergometrina / Maleato de metilergonovina) es un alcaloide derivado del cornezuelo de centeno que produce vasoconstricción arterial periférica generalizada y contracción tetánica miometrial. Por ende, está ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADA en pacientes con antecedentes de preeclampsia, hipertensión arterial gestacional o crónica y cardiopatía isquémica, debido a que su administración puede precipitar una crisis hipertensiva severa con rotura de vasos cerebrales (ACV hemorrágico), edema agudo de pulmón o infarto agudo de miocardio. En esta paciente hipertensa debe utilizarse Misoprostol o Carbetocina. C) Incorrecta. El ácido tranexámico es un antifibrinolítico seguro y mandatorio en HPI. D) Incorrecta. La carbetocina es un análogo de la oxitocina y puede utilizarse. E) Incorrecta. El balón de Bakri es un dispositivo mecánico altamente recomendado.

PREGUNTA 82 **Respuesta: B**

Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado

3.01.1.009 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. En la atonía el útero está blando y subinvolucionado, mientras que aquí está firme y bien contraído. B) Correcta. La presencia de hemorragia genital activa postparto en presencia de un útero FIRME, BIEN CONTRAÍDO e infraumbilical, con placenta íntegra revisada, orienta con certeza a una causa traumática (Trauma de las 4T: desgarros del cuello uterino, de la pared vaginal o del periné). La conducta obligatoria es trasladar a la paciente a sala de partos o pabellón con buena iluminación, instalar valvas ginecológicas para inspeccionar el cuello uterino en sus 360 grados y las paredes vaginales, y proceder a la hemostasia quirúrgica mediante sutura de los desgarros. C) Incorrecta. Si la placenta estaba completa y el útero está contraído, no se justifica legrado a ciegas. D) Incorrecta. El sangrado rutilante localizado con útero duro descarta coagulopatía primaria. E) Incorrecta. En la inversión uterina el fondo desaparece del abdomen y se palpa una masa en vagina.

PREGUNTA 83 **Respuesta: B**

Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado

3.01.1.009 | Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo | GES

A) Incorrecta. El legrado cortante en un útero atónico no detiene el sangrado vascular miometrial y perfora la pared. B) Correcta. El Balón de Taponamiento Intrauterino (Balón de Bakri) es el procedimiento conservador no quirúrgico de rescate de elección ante la atonía uterina refractaria a fármacos uterotónicos. Se inserta en la cavidad uterina y se insufla con 300 a 500 mL de solución salina, ejerciendo una compresión hidrostática uniforme directa sobre los lechos vasculares miometriales. Logra controlar la hemorragia en más del 80-85% de los casos, evitando la laparotomía y preservando la fertilidad de la mujer. C) Incorrecta. La histerectomía es el último recurso quirúrgico definitivo si fracasan las medidas conservadoras. D) Incorrecta. La heparina aumentaría la hemorragia masiva y mataría a la paciente. E) Incorrecta. Dejar avanzar el shock es negligencia médica.

PREGUNTA 84 **Respuesta: B**

Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado

3.01.1.009 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La placenta previa ocurre antes del parto, no en el postparto. B) Correcta. La combinación de tracción excesiva del cordón sobre un útero relajado, colapso hemodinámico severo con bradicardia paradójica (shock neurogénico por tracción de los nervios peritoneales), desaparición del fondo uterino en el abdomen y exteriorización de una masa carnosa globular por la vagina es el cuadro patognomónico de una Inversión Uterina Puerperal. Constituye una emergencia con altísima mortalidad materna. La conducta consiste en: 1) Suspender inmediatamente cualquier uterotónico; 2) Proporcionar soporte circulatorio y analgesia/anestesia profunda para relajar el anillo cervical constrictor; 3) Realizar la Reposición Manual Inmediata (Maniobra de Johnson), empujando el fondo uterino hacia arriba a través del anillo de inversión hacia la cavidad abdominal; y 4) Una vez corregida la posición, recién iniciar oxitocina para mantener el útero contraído. C) Incorrecta. No es una rotura miometrial sino una invaginación de la pared. D) Incorrecta. La embolia de líquido amniótico produce colapso respiratorio con hipoxemia severa sin masa exteriorizada en vagina. E) Incorrecta. El cuadro es una emergencia vital mayor.

PREGUNTA 85 **Respuesta: B**

Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. La vía oral y el manejo ambulatorio están estrictamente contraindicados por el alto riesgo de sepsis y absceso pelviano. B) Correcta. El cuadro de fiebre, dolor uterino, útero subinvolucionado blando y loquios fétidos tras una cesárea corresponde a una Endometritis Puerperal típica. Al tratarse de una infección polimicrobiana que involucra anaerobios estrictos del tracto genital y enterobacterias, el tratamiento de primera línea respaldado por el MINSAL y la literatura médica internacional es la HOSPITALIZACIÓN OBLIGATORIA para antibioticoterapia parenteral combinada con Clindamicina (900 mg cada 8h EV) + Gentamicina (5 mg/kg/día EV en dosis única), manteniéndose hasta que la paciente esté 48 horas afebril. C) Incorrecta. El ciprofloxacino oral no cubre adecuadamente la flora anaerobia miometrial y la vía oral es insuficiente. D) Incorrecta. La dosis única es totalmente ineficaz para erradicar una endometritis. E) Incorrecta. Reservado únicamente para sepsis refractaria en UCI.

PREGUNTA 86 **Respuesta: B**

Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)

3.01.1.010 Dx: Específico · Tx: Completo · Seg: Completo GES

A) Incorrecta. Suspender la lactancia está formalmente contraindicado porque empeora la estasis láctea. B) Correcta. La presentación de fiebre alta, calofríos y una placa eritematosa caliente sectorial unilateral en una mama en el primer mes del puerperio es diagnóstica de Mastitis Infecciosa Puerperal, causada en más del 90% por Staphylococcus aureus procedente de la orofaringe del lactante. El tratamiento de elección consiste en un antibiótico con cobertura antiestafilocócica (Cloxacilina oral 500 mg c/6h o Cefadroxilo 500 mg c/12h) durante 10 a 14 días. La regla de oro fundamental es que NO se debe suspender la lactancia materna; al contrario, debe mantenerse el amamantamiento frecuente y vaciamiento completo del pecho para evitar la estasis de leche que predispone a la formación de un absceso. C) Incorrecta. El drenaje quirúrgico solo está indicado si se ha formado un absceso fluctuante comprobado ecográficamente. D) Incorrecta. La mastitis infecciosa requiere antibióticos orales obligatorios. E) Incorrecta. La cabergolina para inhibir lactancia es un error grave en una mujer que desea amamantar.

PREGUNTA 87 **Respuesta: C**

Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)

3.01.2.006 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: Derivar GES

Es una endometritis puerperal clásica.

PREGUNTA 88 **Respuesta: C**

Infecciones Puerperales: Endometritis Puerperal y Patología Mamaria (Mastitis Congestiva vs Infecciosa vs Absceso)

3.01.2.009 Dx: Específico · Tx: Inicial · Seg: No requiere GES

Tiene una mastitis puerperal, por lo que solo se deben indicar antibióticos con cobertura de gram positivos (cefazolina endovenosa o amoxicilina + ácido clavulánico oral). Si hubiese tenido un absceso, pues, además se drena. No es necesario suspender la lactancia, sino mejorar la técnica de lactancia.

PREGUNTA 89 **Respuesta: B**

Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal: Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D y Manejo de la Gestante Sensibilizada

3.01.1.012

Dx: Específico
· Tx: Completo
· Seg: Completo

GES

A) Incorrecta. No hay justificación de interrupción; el embarazo es fisiológico y sano. B) Correcta. En toda gestante Rh negativa no sensibilizada (confirmada por un Test de Coombs Indirecto negativo), las guías clínicas de MINSAL y los consensos internacionales indican la administración profiláctica rutinaria de Inmunoglobulina Anti-D a dosis de 300 mcg (1.500 UI) por vía intramuscular a las 28 semanas de gestación. Esta dosis antenatal previene la sensibilización materna que puede ocurrir por microtransfusiones feto-maternas asintomáticas durante el tercer trimestre. Si el recién nacido resulta ser Rh positivo al nacer, se administrará una segunda dosis dentro de las 72 horas postparto. C) Incorrecta. Esperar solo al postparto deja una ventana de riesgo de sensibilización del 1-2% en el tercer trimestre. D) Incorrecta. La amniocentesis es invasiva y solo se realiza ante sospecha de anemia en sensibilizadas graves. E) Incorrecta. El plasma no aporta anticuerpos anti-D terapéuticos.

PREGUNTA 90 **Respuesta: B**

Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal: Profilaxis con Inmunoglobulina Anti-D y Manejo de la Gestante Sensibilizada

3.01.1.012

Dx: Específico
· Tx: Completo
· Seg: Completo

GES

A) Incorrecta. La administración de inmunoglobulina anti-D en una mujer ya sensibilizada (Coombs positivo) es totalmente inútil, pues la profilaxis previene la respuesta inmune primaria pero no tiene ningún efecto sobre los linfocitos B de memoria ya activados ni sobre los anticuerpos preexistentes. B) Correcta. La paciente es una gestante Rh (-) SENSIBILIZADA con títulos de anticuerpos de 1:64, muy por encima del título crítico (1:16). Por ende, está formalmente contraindicada la inmunoglobulina anti-D y la paciente debe ser derivada a la Unidad de Medicina Materno-Fetal para seguimiento con Doppler de la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media (ACM) a partir de la semana 18-20 para pesquisar anemia fetal moderada a grave de forma no invasiva. C) Incorrecta. La exanguinotransfusión materna no tiene rol en la aloinmunización. D) Incorrecta. La tasa de supervivencia con transfusión intrauterina supera el 90%. E) Incorrecta. Los anticuerpos de la aloinmunización son de clase IgG y cruzan activamente la placenta.
